

地域保健・地域医療

保健所・保健センター

名古屋市健康福祉局医務担当局長／名古屋市保健所長 小嶋 雅代

KEY WORDS

各2~3行で説明できるようにしておく

- 地域保健法（保健所、保健センター、衛生研究所）
- 健康の社会的決定要因
- 健康増進法
- 健康日本21（第3次）

該当するコアカリ項目

- GE-04-01-01 患者の健康観や病いに対する価値観を理解するうえで、健康に関わる知識(定義、健康寿命、健康生成論、ウェルビーイング、QOL、SDH、ICF、UHC等)を活用し、健康問題に対する包括的アプローチが実践できる。
- SO-01-03-01 保健所、市町村保健センター、地方衛生研究所の役割を理解している。
- SO-01-03-02 健康増進法、栄養、身体活動、休養等の健康増進施策の意義と概要を理解している。
- SO-01-03-03 地域保健に関連する基本的な制度や法律を理解している。

医師法（1948年）

第一条

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

上 医 医 国
中 医 医 民
下 医 医 病

西暦454年から473年にかけて書かれた、陳延之の著書「小品方」より

本日の話題

1. 保健所・保健センター、地域保健法
2. 健康とは？
3. 健康増進法

参考資料

- 名古屋市・保健センターのご案内
- 国民衛生の動向
- 公衆衛生がみえる

保健所とは

保健所は地域保健法に基づいて設置された公的な健康管理機関。

保健所は都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されており、全国で462カ所ある。

保健所設置市：以下の要件を満たした場合は設置可。

- ①人口20万人以上（中核市）
- ②保健所を設置・運営するための人的・技術的・財政的な能力がある
- ③都道府県知事の同意を得て、厚生労働大臣が承認

＊その他の政令で定める市（小樽、町田、藤沢、茅ヶ崎、四日市）



政令市と中核市

項目	政令指定都市(政令市)	中核市
法的根拠	地方自治法第252条の19	地方自治法第252条の22
人口要件	50万人以上	20万人以上(例外あり)
都道府県からの権限移譲	最大規模の権限移譲(県に準ずる)	政令市よりは少ないが 大幅な権限移譲
保健所設置	必置(政令市は必ず設置)	必置(中核市は必ず設置)
保健所の役割	県レベルに近い広域的機能を持つ	市域の保健行政を担う(政令市より規模は小)
医療法に基づく事務	医療計画の一部、医療機関の許認可など 県並みの権限	医療機関の許認可など 多くの県事務を受託
児童相談所	設置可能(任意、8市が設置済)	設置可能(任意、4市が設置済)
保健所数の傾向	本所+複数の支所(例:名古屋市は1本所+16支所)	多くは 1保健所のみ
財政規模	非常に大きい(県に次ぐ規模)	政令市より小さいが一般市より大きい
代表例	大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市など20市	豊田市、豊橋市、岡崎市、一宮市、金沢市、浜松市、鹿児島市など62市

保健所の設立と役割の変化



最初の保健所法は1937年に制定。保健所は健兵健民政策を進めるための手段。敗戦までに全国で計770カ所の保健所網が整備。

1

昭和12年（1947）

結核・伝染病、低栄養、
不衛生な生活環境

1937年、保健所法の制定により、公衆衛生行政の体制が整備された。1947年に改正され、保健所は、健康相談や保健指導に加え、医事、薬事、食品衛生、環境衛生など多岐にわたる行政機能を担う中心機関として位置付けられた。

2

平成6年（1994）

成人病、認知症への対応

地域保健法の制定により、感染症対策など広域にまたがる事務については、都道府県が引き続き担う一方、老人保健や母子保健などは市町村の保健センターに再編。保健所と福祉事務所の統合が進み、県型保健所数が減少。

3

現在

生活習慣病、国際感染症、
自殺対策、大規模災害

市型保健所数が増加し、保健所の機能が多様化しています。一方で、新型コロナウイルス感染症への対応で、保健所の健康危機管理機能の強化が求められています。

地域保健法(1994年)

1994年に「保健所法(1947)」を改正し「地域保健法」を制定

保健所や市町村保健センターなどの設置・運営、及びそれらの機能による地域保健活動の基本を定めた法律

都道府県と市町村の役割分担を見直し、母子保健サービス等の実施主体を市町村とすることで、住民に身近な保健サービスの一元的な提供を可能とした

「地域保健対策の推進に関する基本指針」の策定を規定

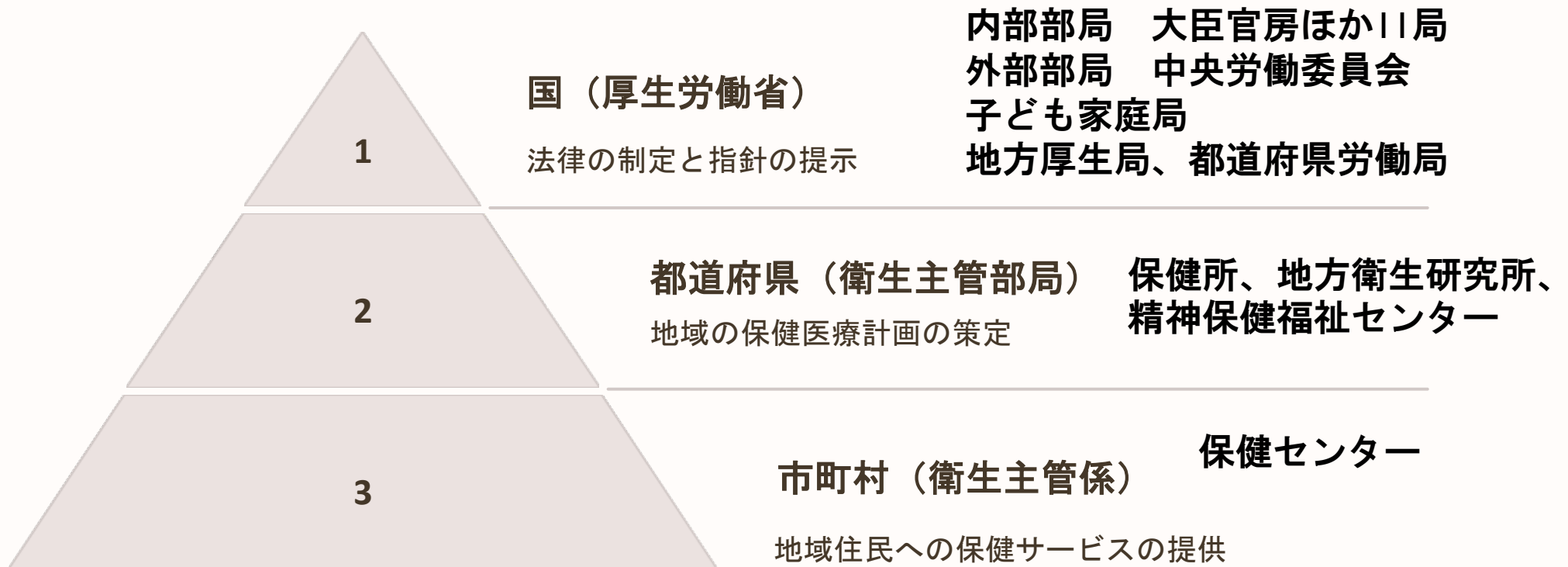
「地域保健対策の推進に関する基本指針」

1. 地域保健対策の基本的な方向
2. 保健所・保健センターの整備・運営に関する基本的事項
3. 人材確保・資質向上、人材確保支援計画の策定に関する基本的事項
4. 調査・研究に関する基本的事項
5. 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項
6. その他、地域保健対策の推進に関する重要事項

これまでに4回改正

- ① H12(2000)年 阪神・淡路大震災、介護保険の施行⇒健康危機管理体制の確保、健康日本21の推進
- ② H15(2003)年 健康増進法の施行⇒次世代育成支援対策、精神障害者施策、児童虐待防止対策の推進
- ③ H24(2012)年 東日本大震災⇒ソーシャルキャピタルを活用した自助・共助の推進、医療・介護・福祉の連携
- ④ R04(2022)年 COVID19パンデミックの終息⇒健康危機管理体制の強化、精神保健に課題を抱える者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保、健康日本21第3次への対応

一般衛生行政の体系



地域保健法に基づいて、国、都道府県、市町村が協力して地域の保健医療体制を整備しています。国は法律の制定と指針の提示を行い、都道府県は地域の保健医療計画を策定します。一方、市町村は住民に直接保健サービスを提供する中心的な役割を担っています。この3者が連携して、地域の実情に合った効果的な保健活動を展開しています。

保健所と保健センターの違い

設置主体の違い

保健所は都道府県が設置する公的機関ですが、保健センターは市町村が設置しています。地域の実情に合わせたサービス提供が可能です。

担当地域の範囲

保健所は広域的な管轄範囲を持つ一方、保健センターは市町村内の近隣地域を担当し、住民に身近な存在です。

提供サービスの違い

保健所は専門性の高い保健医療サービスを提供しますが、保健センターは予防や健診、健康相談、健康づくりに重点を置いた比較的簡易な事業を行います。

保健所長と保健センター長の違い

項目	保健所長	保健センター長
設置主体	都道府県・政令指定都市・中核市など	市町村（市区町村）
主な役割	地域全体の広域的・専門的な公衆衛生業務の総括責任者	地域住民に対する身近な保健サービスの提供責任者
担当範囲	感染症対策、食品衛生、環境衛生、医療機関の監視・指導など	健康相談、母子保健、健康教育、予防接種、介護予防など
資格要件(実質)	原則として医師免許を持つ者	明確な資格要件なし(多くは保健師・行政職など)
対象業務のレベル感	行政的・法的権限が大きく、監視・命令・勧告なども行える	主に地域住民への支援・相談・予防活動など実務中心

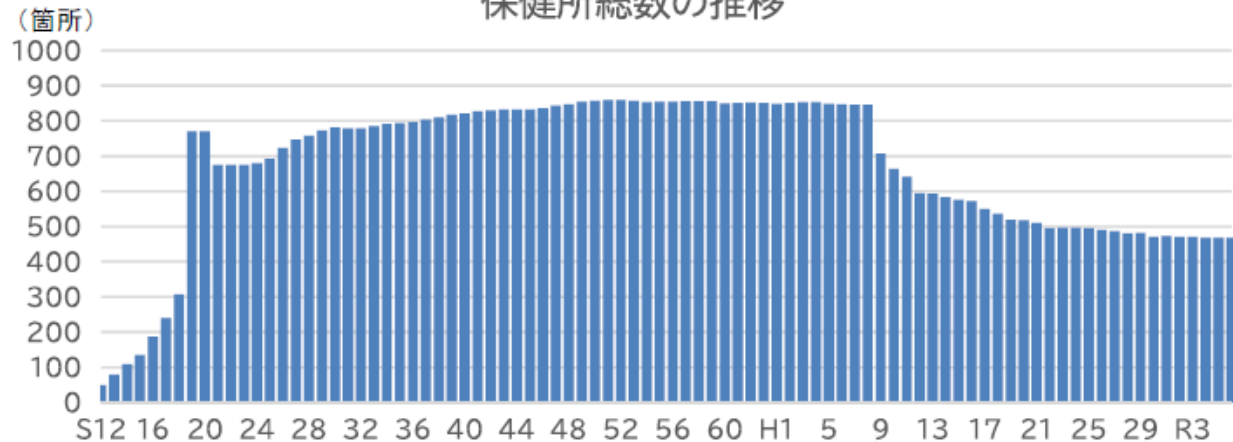
保健所の数

令和7年4月現在、462か所。

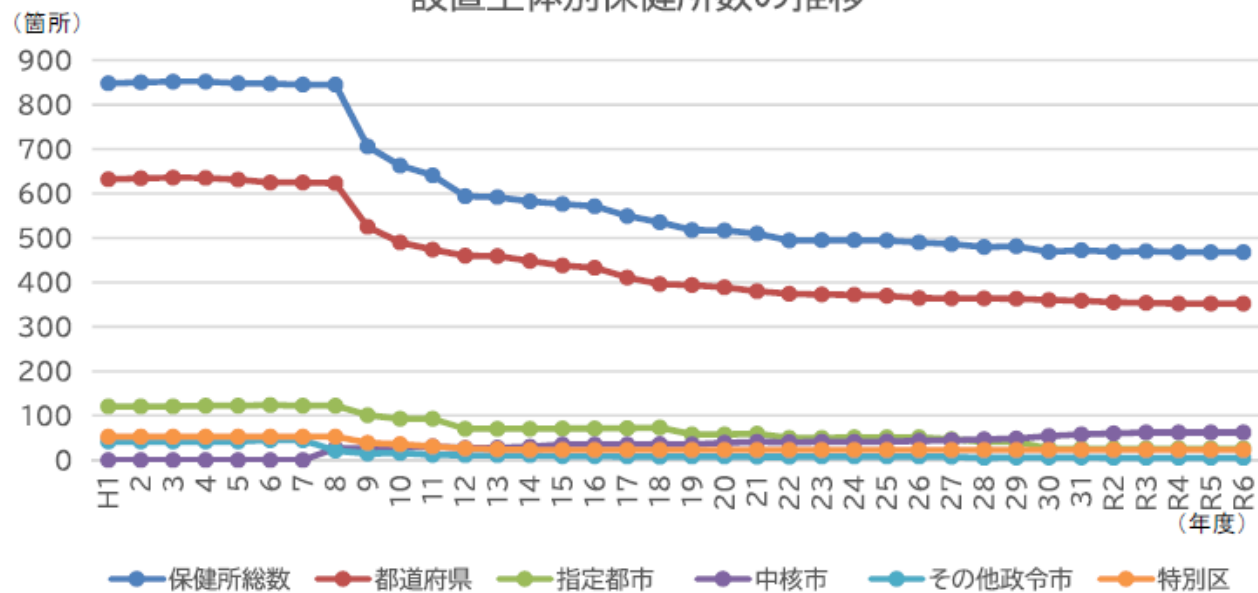
平成6年の地域保健法制定以降、急速に集約化が進んでいる。

保健所数の推移(厚生労働省健康・生活衛生局健康課地域保健室調べ)
(令和6年4月1日現在)

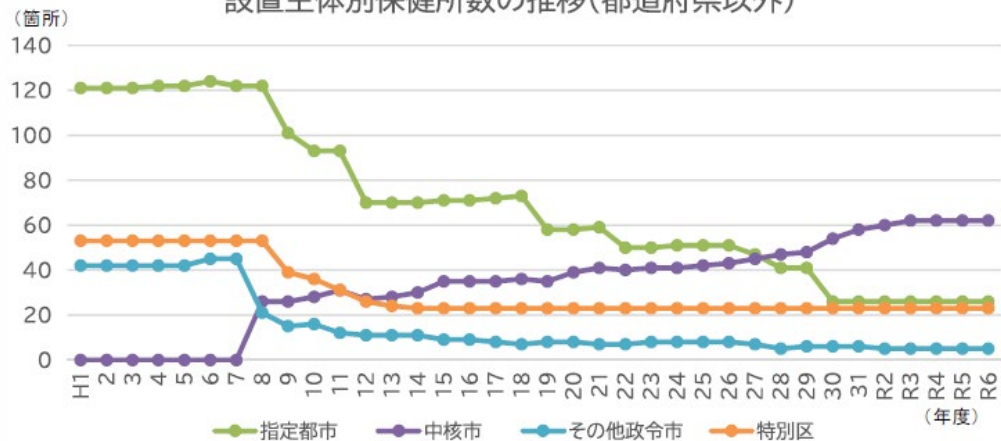
保健所総数の推移



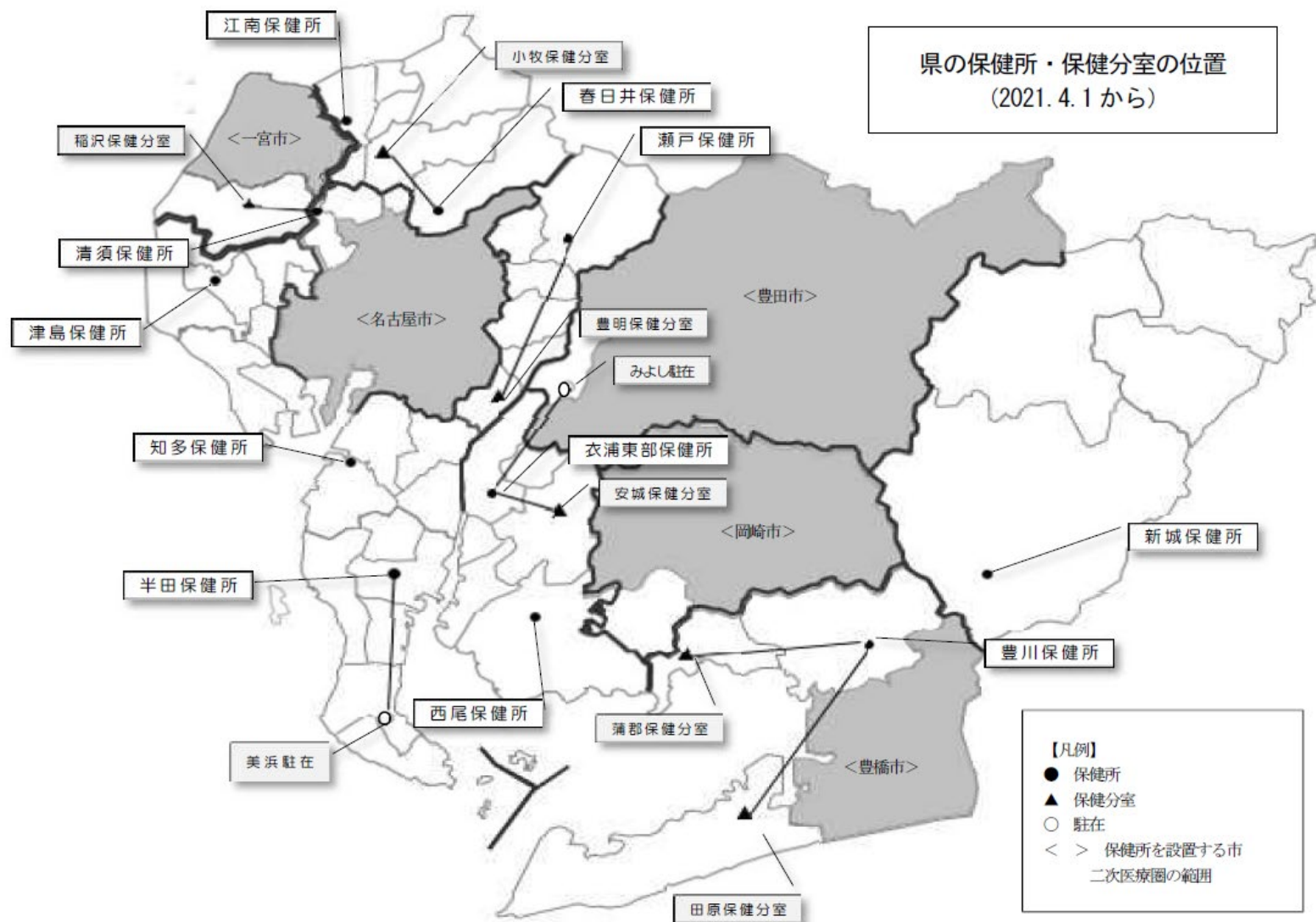
設置主体別保健所数の推移



設置主体別保健所数の推移(都道府県以外)



愛知県内の保健所



保健所の役割

- 保健所が担う業務は、大きく「対人保健」「対物保健」「企画調整」の三つに分類されます。
- 対人保健業務には感染症対策やエイズ・難病対策、精神保健対策、母子保健対策などが含まれます。
- 対物保健業務には食品衛生関係業務、生活衛生・環境衛生関連の業務などが含まれます。
- 企画調整業務には、地域の医療計画の立案や維持、所管の市町村全域にわたる調整、医事・薬事衛生業務などが含まれます。

DOCTORASE

保健所長に届け出るもの

(保健所長⇒都道府県⇒国)

【1. 感染症関係(感染症法)】

- 感染症患者・無症状病原体保有者を診断した場合の届出
(例:結核、COVID-19、梅毒、麻しん、風しんなど)
- 感染症死亡者の届出
- 感染症の発生届(集団発生、院内感染など)
- 動物由来感染症(狂犬病など)の届出

【2. 食品衛生関係(食品衛生法)】

- 飲食店営業、食品製造業などの営業許可申請・変更・廃止届
- 食中毒の発生届
- HACCP(衛生管理計画)の導入報告(※一部事業者対象)
- 営業施設の構造設備変更届
- 食品等事業者の届出(届出制対象業種)

【3. 医療関係(医療法など)】

- 医療機関の開設・変更・廃止届
- 診療所、助産所などの開設届(開設後10日以内)
- 医師・看護師等の就業状況届(年1回)
- 医療事故報告
- 医療機関における感染対策委員会の設置報告
(必要な場合)

【4. 薬事関係(薬機法など)】

- 薬局、医薬品販売業の許可申請・変更・廃止届
- 医薬品の回収報告
- 医療機器製造・販売の届出・許可関連

【5. その他】

- 化粧品・医薬部外品の製造販売届
- 理容所・美容所の開設・変更・廃止届
- 墓地・火葬場の設置・変更の届出
- 動物取扱業に関する届出(ペットショップなど)

次の1から3のうちのいずれかの状況(報告基準)に該当する場合は、保健所への報告をお願いします。

同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全入院者の半数以上発生した場合

1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に医療機関の管理者が報告を必要と認めた場合



保健所の未来像

1

健康危機管理の拠点

保健所は地域における健康危機管理の中心的な役割を担う必要があります。

2

地域連携の強化

医療機関、市町村、医師会など、地域の関係機関との連携を一層強化していく必要があります。

3

行政機能の充実

自然災害や新興感染症への対応など、保健所の行政機能をさらに強化していく必要があります。

保健所の職員

保健所には医師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士など、多様な専門職が配置されている。

- 医師：感染症予防や難病対策、精神保健福祉サービスの提供など、医学的見地からの助言や指導を行う。
- 保健師：健康教育や健康相談、家庭訪問など、地域住民の健康支援に重要な役割を果たしている。
- 薬剤師：医薬品の適正使用の推進や服薬指導、毒物劇物の取り締まりなどを担当。
- 獣医師：食品安全の監視、動物に関連する疾病管理、福祉監視、公衆衛生の促進、法的支援
- 管理栄養士：給食施設の監視指導や食品衛生指導、栄養改善事業の企画など、地域の食生活改善に携わる。

保健所長の資格要件 地域保健法施行令第4条1項

保健所の所長は、医師であり、①～③のいずれかを満たす者

- ① 3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
- ② 国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(「専門課程」ⅠまたはⅡ)を修了した者
- ③ 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有する*と認めた者

*外国の専門課程を修了し、公衆衛生修士(MPH、MSPH)の学位を取得した者

ただし、当分の間、医師免許取得後、公衆衛生関係の研究若しくは教育に3年以上従事した経験又は診療に5年以上従事した経験を有し、「専門課程Ⅰ」の科目のうち別表1に掲げる6科目を受講し、12単位を修得した者は③として取り扱う。医師免許取得後、保健所若しくは地方公共団体又は国の衛生主管部局に1年以上勤務した経験を有する者については、その勤務期間をそれぞれの経験年数に算入することができるものとする。

(平成21年3月31日)
(健発第0331041号)

保健所長の資格要件の見直し 平成16年4月

- 近年、健康危機管理への対応を始め、地域の安全・安心の拠点としてより高い管理能力が保健所に求められており、今後より高い水準の保健所長を確保することを目指す。そのような保健所長医師を確保するために、公衆衛生医師の養成及び確保に積極的に取り組むが、そのような努力を行っても公衆衛生に精通した適切な医師が確保できない場合には、以下の条件の下、例外的措置として、医師以外の者を保健所長とすることを可能にする。

見直し概要

- (1) 医師以外の者とは以下の(1)～(3)を満たす者をいう。
- (1) 公衆衛生行政に必要な医学的専門知識に関し医師と同等またはそれ以上の知識を有する
技術吏員（歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、栄養士など）
- (2) 一定期間以上の公衆衛生の実務経験（5年）
- (3) 一定の養成訓練の課程※を修了 ※ 国立保健医療科学院の保健所長用1年コース
- (2) 地方公共団体が医師確保に努力したにもかかわらず確保が出来ない場合に例外を認める。
- (3) 例外の期間は、概ね2年程度とする。
- (4) 医師を保健所の職員として必置する。

予備試験と本試験、2回試験あり！

H21年にさらに緩和
20年以上勤務歴があれば、予備試験は免除、
研修3ヶ月でOK、同一保健所4年まで可。

地方衛生研究所とは？

① 感染症対策の科学的支援

- 感染症の病原体検査・同定・分離培養
- 疫学調査（感染経路、発生源などの追跡調査）
- 新興・再興感染症（例：COVID-19、結核など）への迅速対応
- 感染症発生時の保健所や医療機関への技術支援

② 食品衛生の監視・検査

- 食品中の細菌・ウイルス・化学物質（残留農薬、添加物など）の検査
- 食中毒発生時の原因調査と対策
- 輸入食品や流通食品の安全性評価

③ 環境衛生の検査・監視

- 飲料水やプール水の水質検査
- 大気、土壌、河川の環境測定・調査
- 騒音、振動、悪臭など生活環境に関する苦情対応と調査

④ 化学物質や薬物の分析

- 中毒事故や事件での毒物・薬物分析
- 医療事故や異物混入事件などへの技術対応
- 環境中に存在する有害化学物質の検出とリスク評価

⑤ 調査研究・地域特有の健康課題への対応

- 地域で発生している健康問題に関する自主研究・疫学調査
- 研究成果を政策提言や保健施策に活用
- 国（厚生労働省や感染研）と連携した研究活動

⑥ 保健所や関係機関への技術支援・研修

- 保健所職員や衛生監視員、医療機関職員などへの研修・技術指導
- 感染症対応マニュアルや検査技術の開発と普及

⑦ 公衆衛生危機管理の中核機関

- 災害、感染症パンデミック、環境汚染など緊急時の初動対応
- リスク評価・迅速検査体制の確立と調整役



名古屋市の保健所の変遷

従来の保健所

名古屋市では、全区に保健所が設置されていました。

保健福祉センターへの移行

平成30（2018）年4月に保健所が1カ所に統合され、従来の各区の保健所は保健所支所・保健福祉センターとなりました。

保健福祉センターの役割

保健福祉センターは、予防接種、健康相談、健康診査など、市民にとって身近で利用頻度の高い「対人保健サービス」の提供が主たる役割となっています。



名古屋市公衆衛生医師の役割

- 大規模事例が発生した場合の危機管理業務（アウトブレイク、食中毒、動物・環境由来感染症等）
- 災害対応（非常配備、避難所運営、保健救護班への参加等）
- 地域における防災訓練への従事 など

健康危機管理 防災活動

感染症予防 ・対策

- 発生時対応（届出受理、情報収集、接触者健診など）
- 性感染症検査（HIV・梅毒検査）
- 教育・啓発活動（訓練の実施など）
- 予防接種関係業務（接種間違い発生時の対応など）

食品衛生 食中毒予防

- 営業許可
- 食中毒予防

母子保健

- 乳幼児健診（3か月健診、1歳6か月児健診及び3歳児検診の運営など）

病院・診療所 等の立入検査

- 病院・診療所等の許可及び届出の受理
- 医療監視

成人保健 健康づくり

- 健康教室・地域保健活動
- 地域包括ケアの推進（関係機関との連携など）
- がん予防検診の推進

情報発信

- 広報・啓発（掲示物・出版物の作成、報道機関の取材対応 など）

難病保健 ・対策

- 難病患者・家族への支援

人材育成 ・確保

精神保健 自殺対策

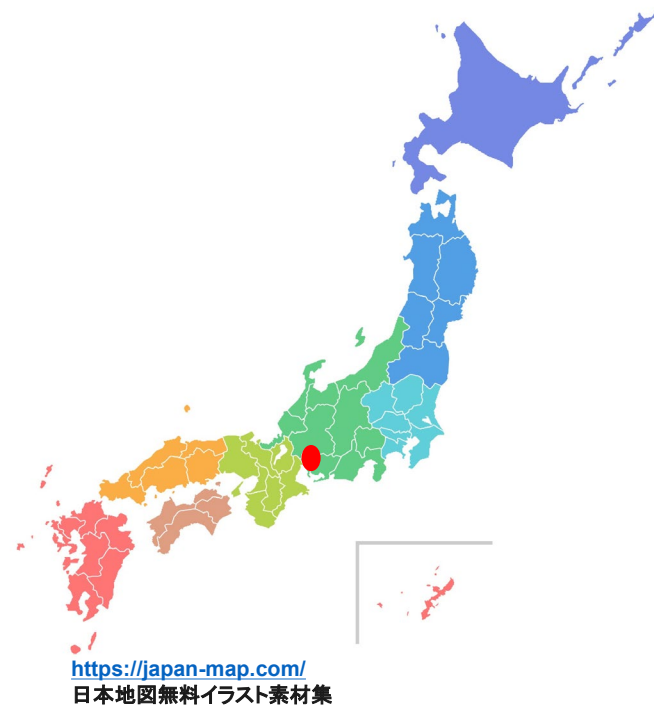
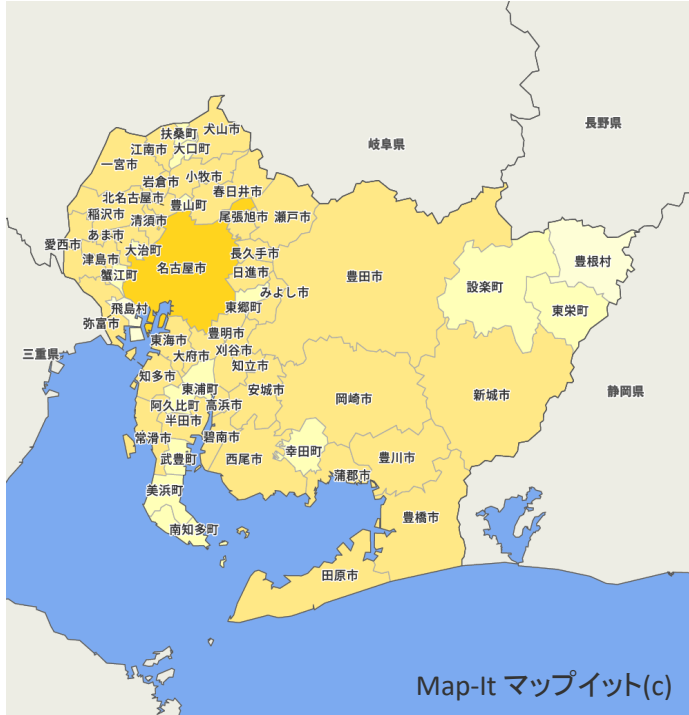
- 医学生・医師対応及び募集（実習や見学などの対応）
- 人材募集に係る事業への参加や資料作成など
- 各種研修への参加、公衆衛生医師研究会による業務研究や伝達講習 など

- こころの健康相談

名古屋市、TIME誌の World's Greatest Places 2023に選ばれる！

<https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2023/6261808/nagoya-japan/>

Nagoya, Japan
Anime and whiskey



名古屋市においても、今後は少子高齢化が進行

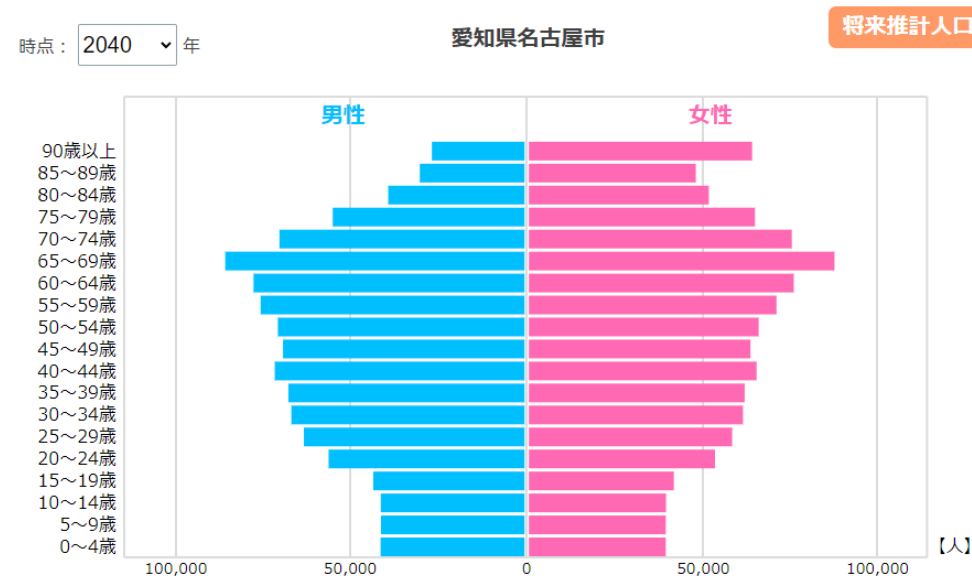
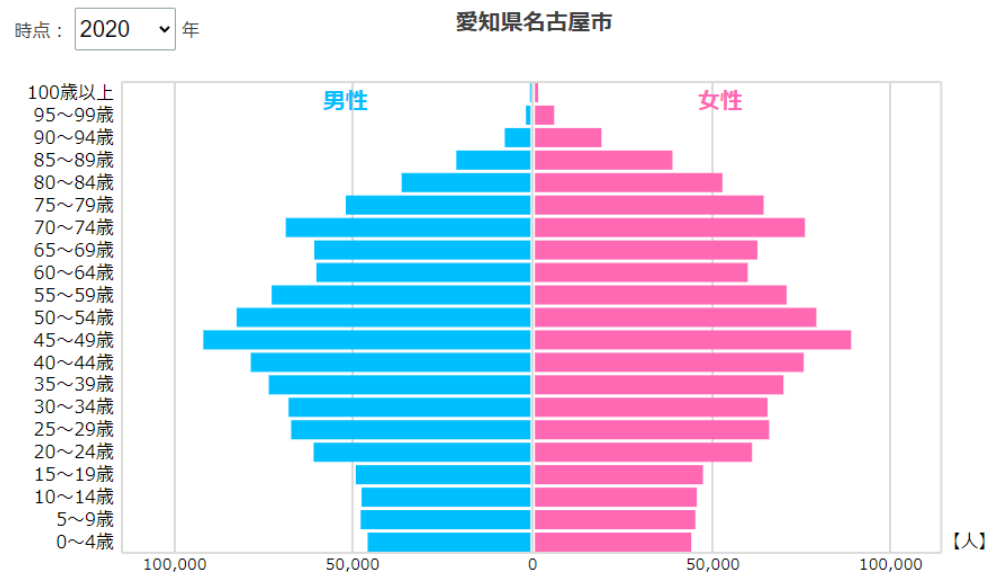
65歳以上の高齢者が人口に占める割合

総務省 統計ダッシュボード

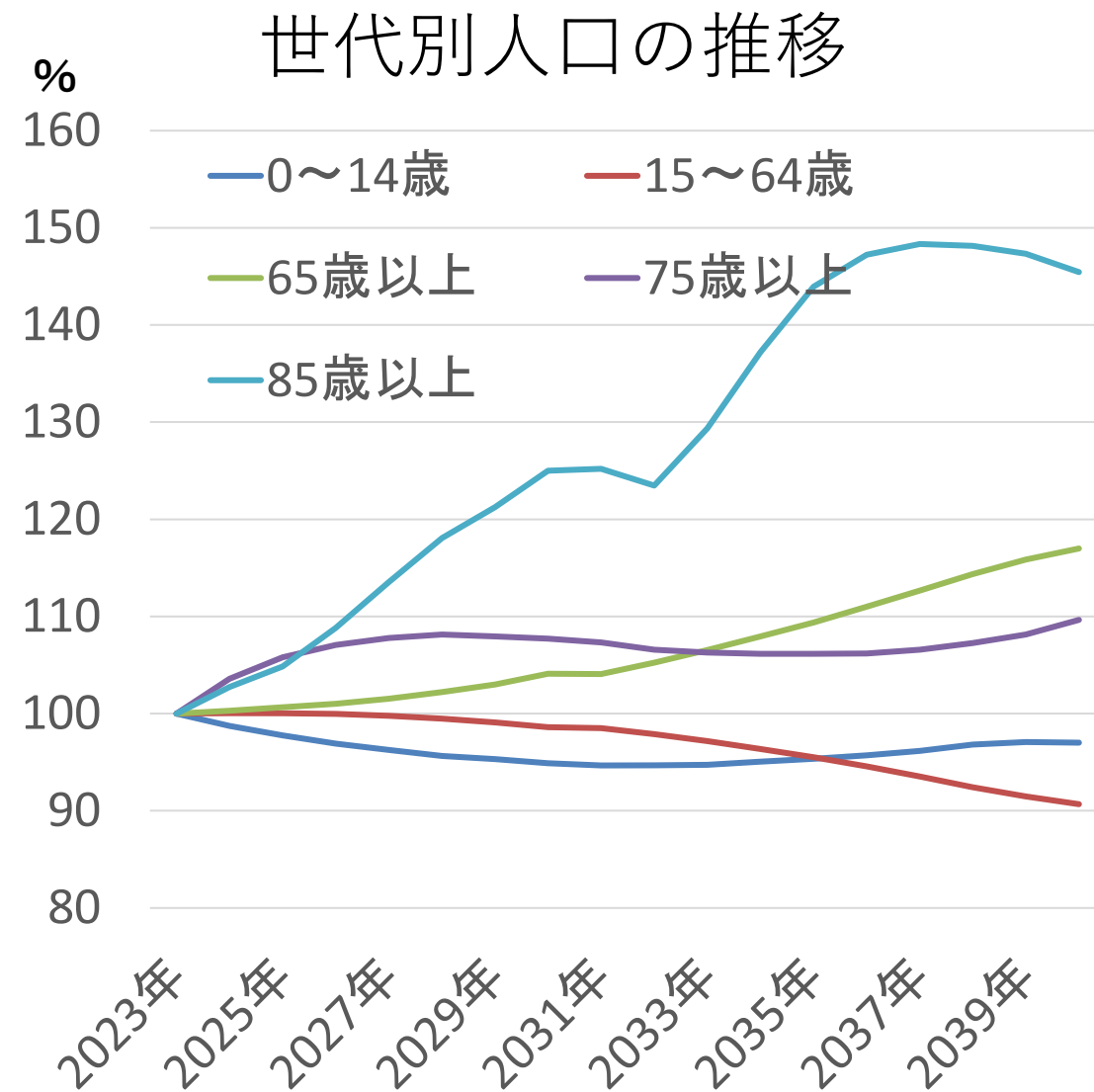
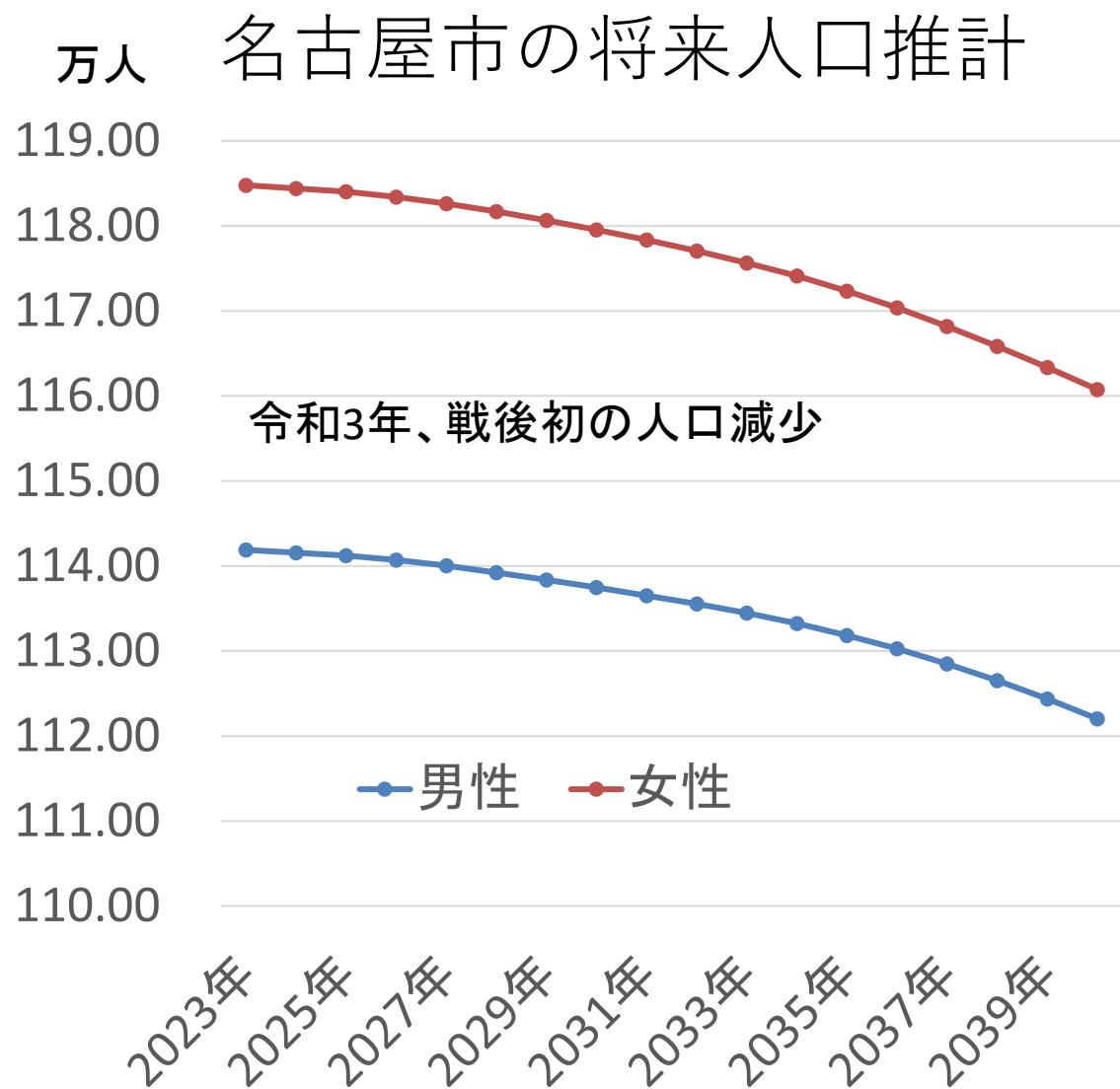
<https://dashboard.e-stat.go.jp/>

2020年 25.4%

2040年 31.4% (推計値)



今後の名古屋市では85歳以上の高齢者が急増



高齢者人口の増加に伴う最大の課題

増大する医療・介護需要への対応



医療・介護費の適正化

質の向上と効率化



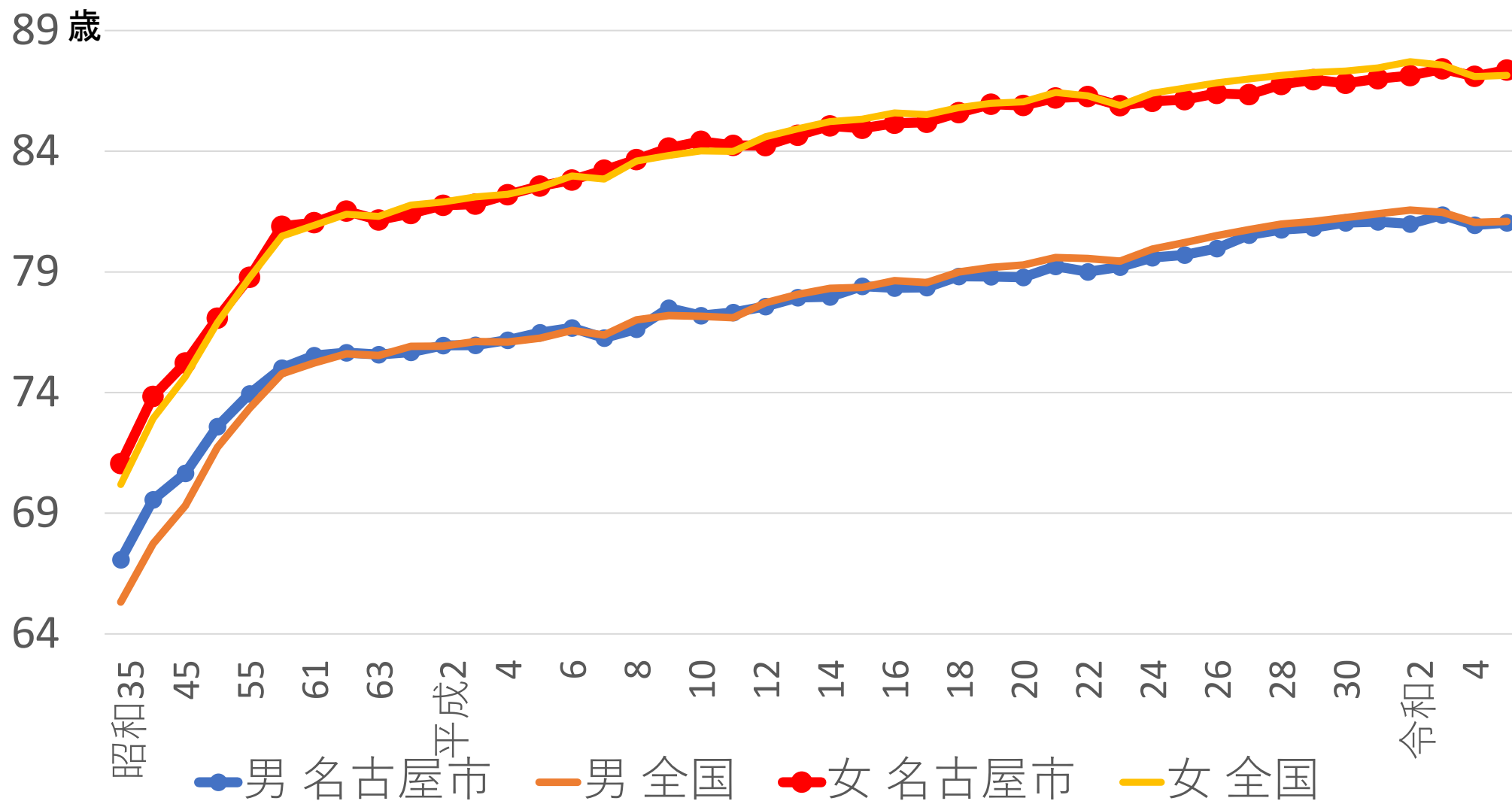
健康寿命の延伸

介護予防と健康づくりの推進

誰もが最期まで自分らしく暮らせる街づくりの実現

エビデンスの継続的な収集・分析が不可欠

名古屋市の平均寿命はほぼ全国と同じ



健康寿命とは

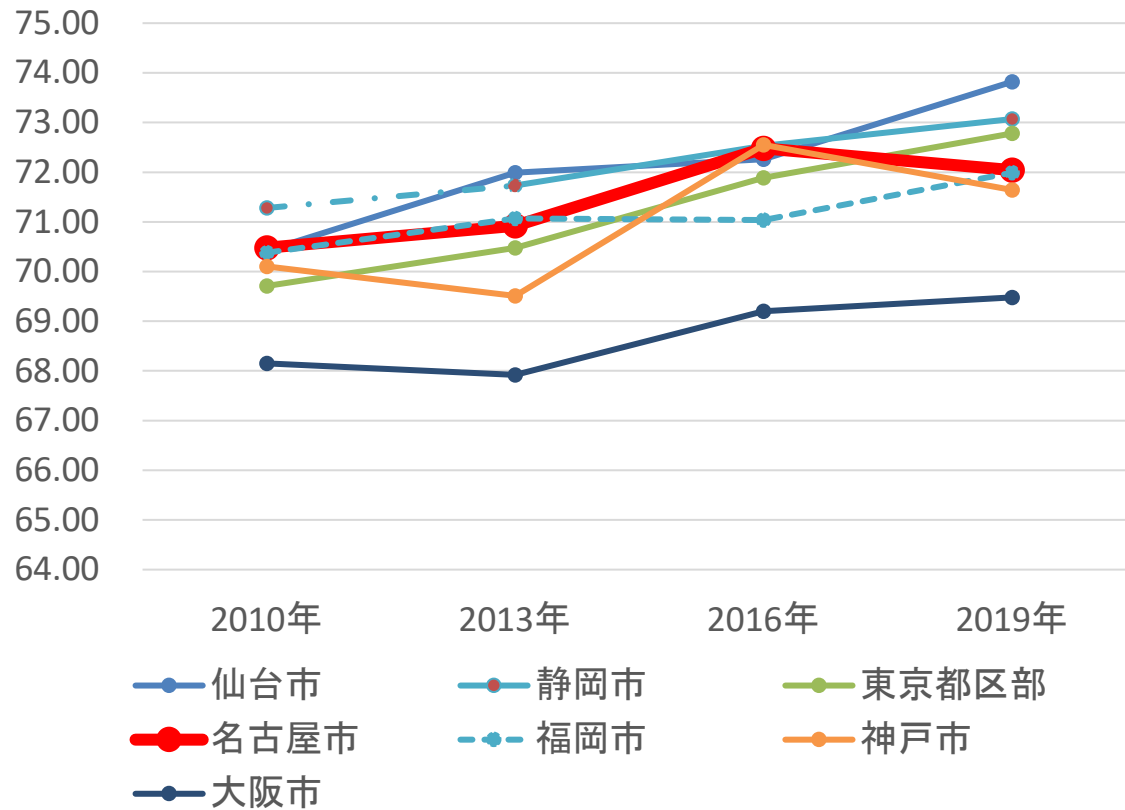
平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間。

WHO(世界保健機関)が提唱した指標で、平均寿命から、衰弱・病気・痴呆などによる介護期間を差し引いたもの。

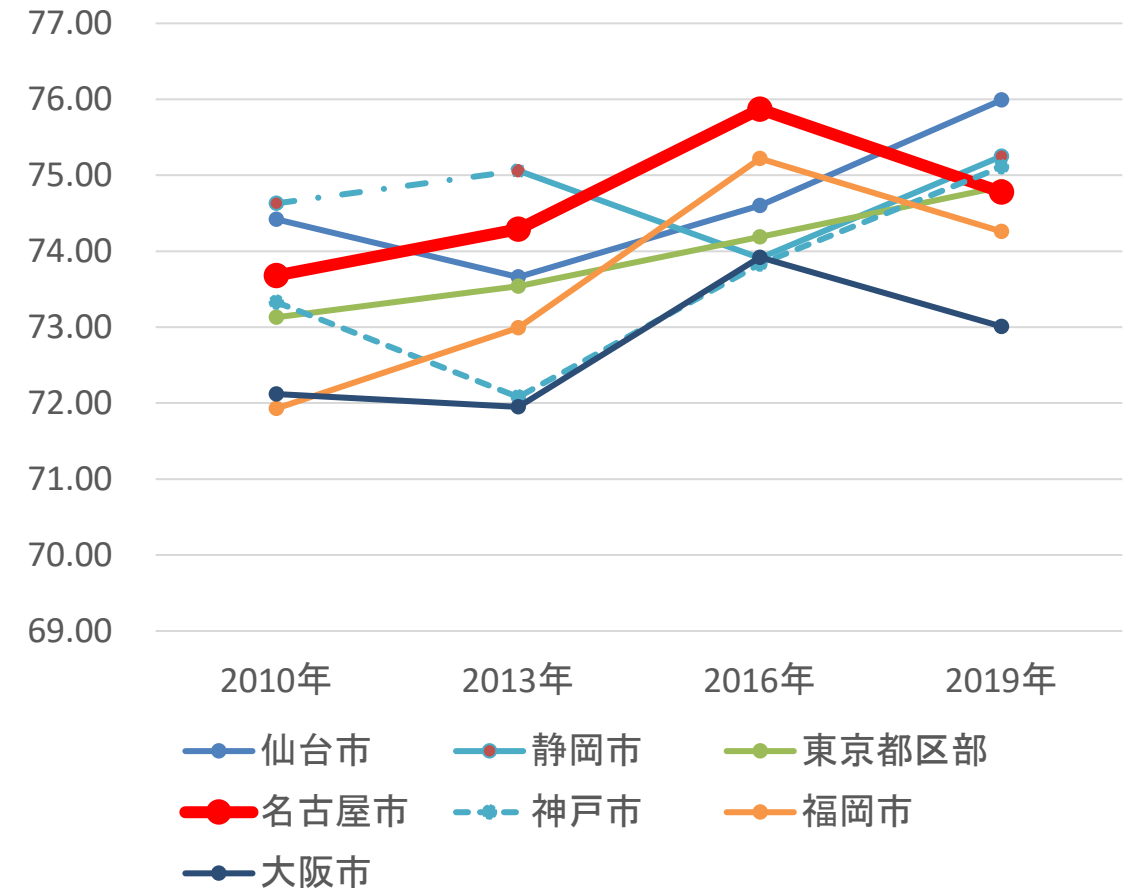
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間(厚労省)

大都市の健康寿命の年次推移比較

男性の健康寿命

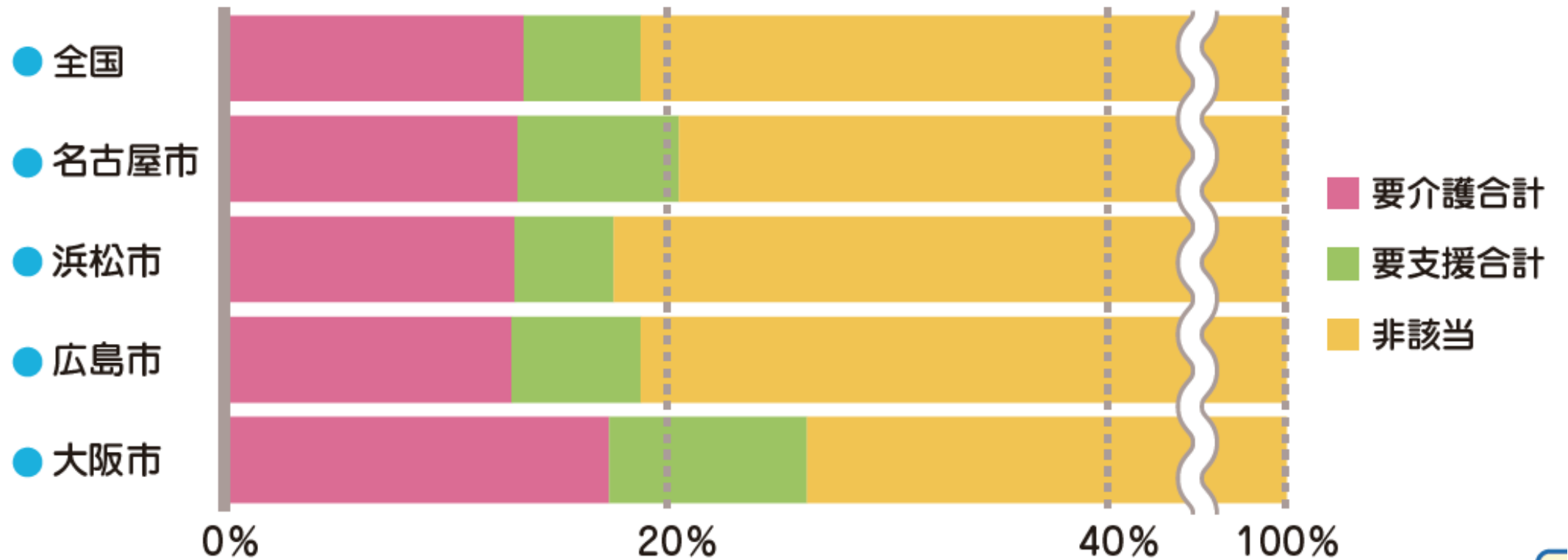


女性の健康寿命



名古屋市の要介護率はほぼ全国並み

全国と他の政令指定都市の要支援・要介護認定割合
(令和3年度)

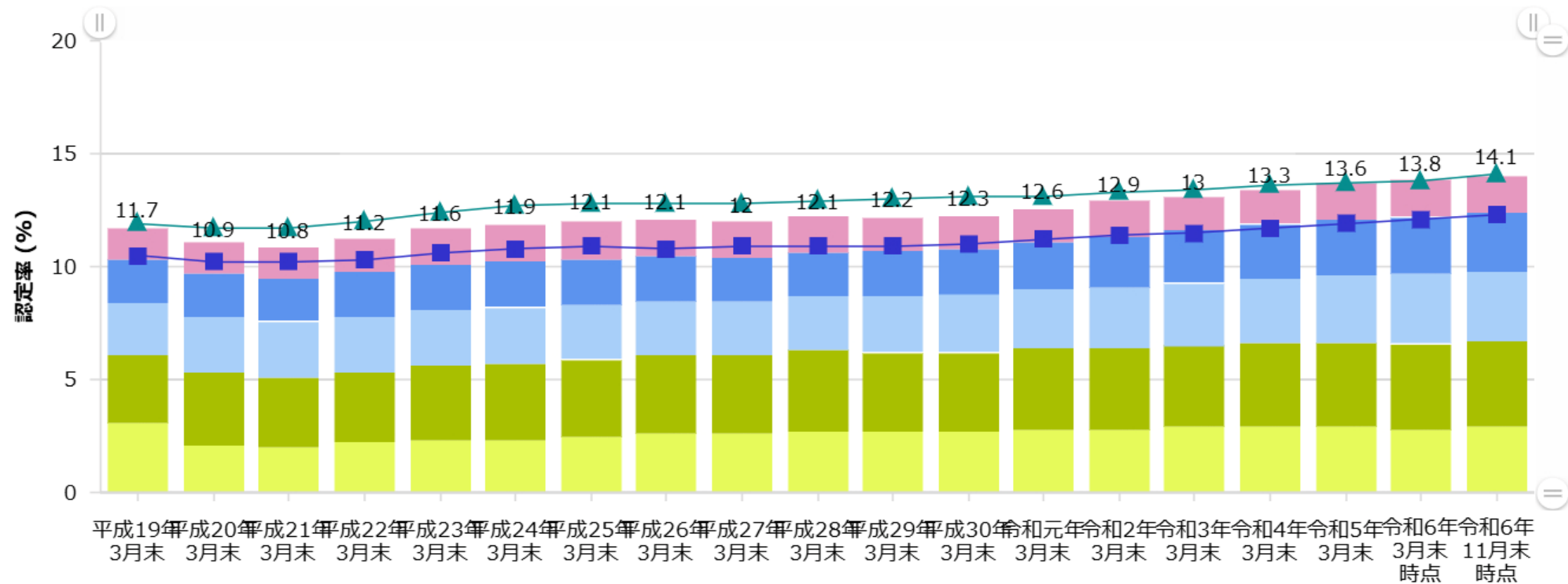


出典：厚生労働省老健局介護保険計画課・介護保険事業状況報告

認定率（要支援除く）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 全国 愛知県

名古屋市の要介護率は年々増加している

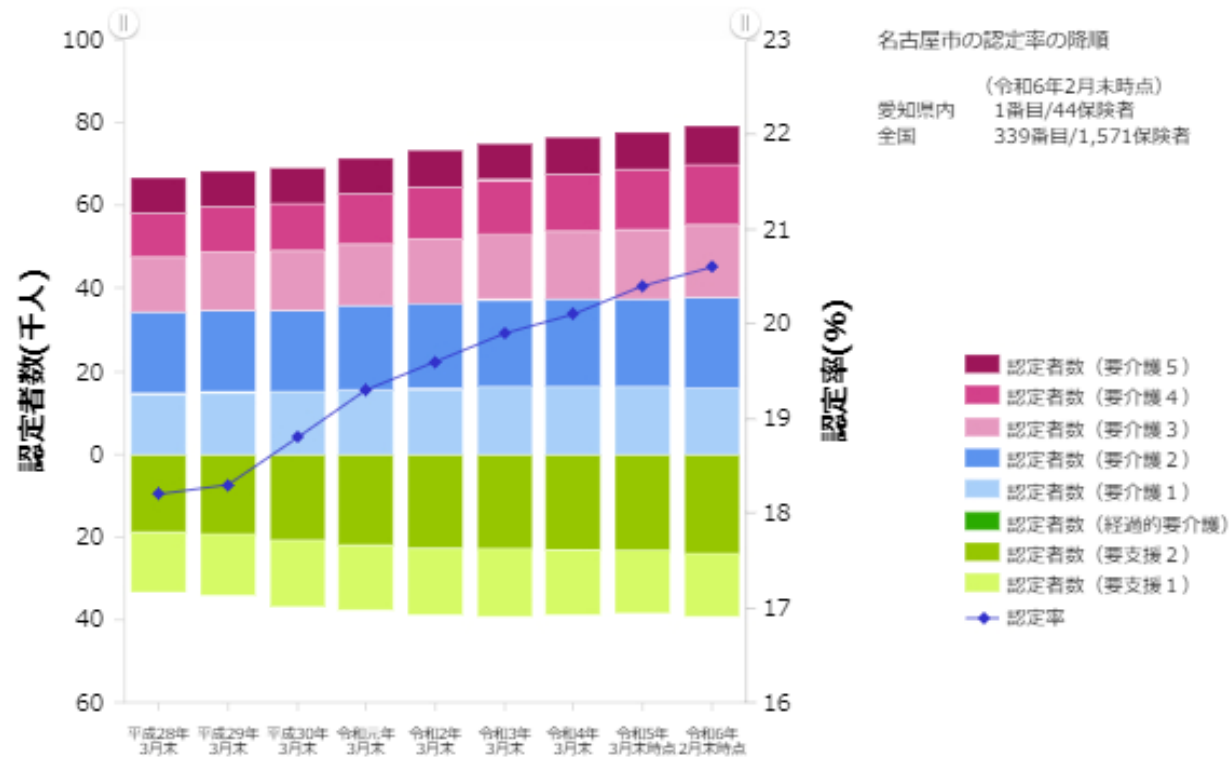


（注目する地域）名古屋市

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和5,6年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

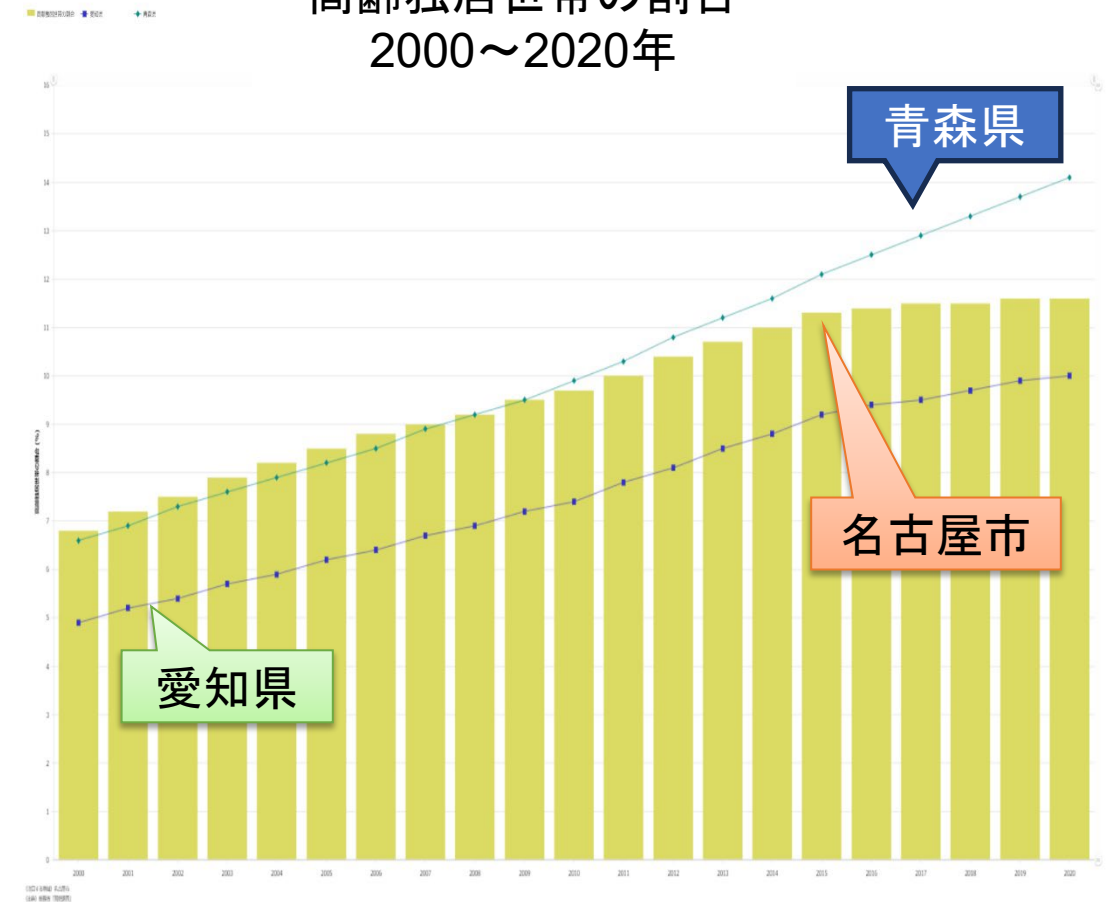
名古屋市の要介護認定率、高齢独居世帯の割合は年々増加

名古屋市の要介護（要支援）認定者数、要介護（要支援）認定率の推移



(出典) 平成27年度から令和3年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和4年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」、令和5年度：直近の「介護保険事業状況報告（月報）」

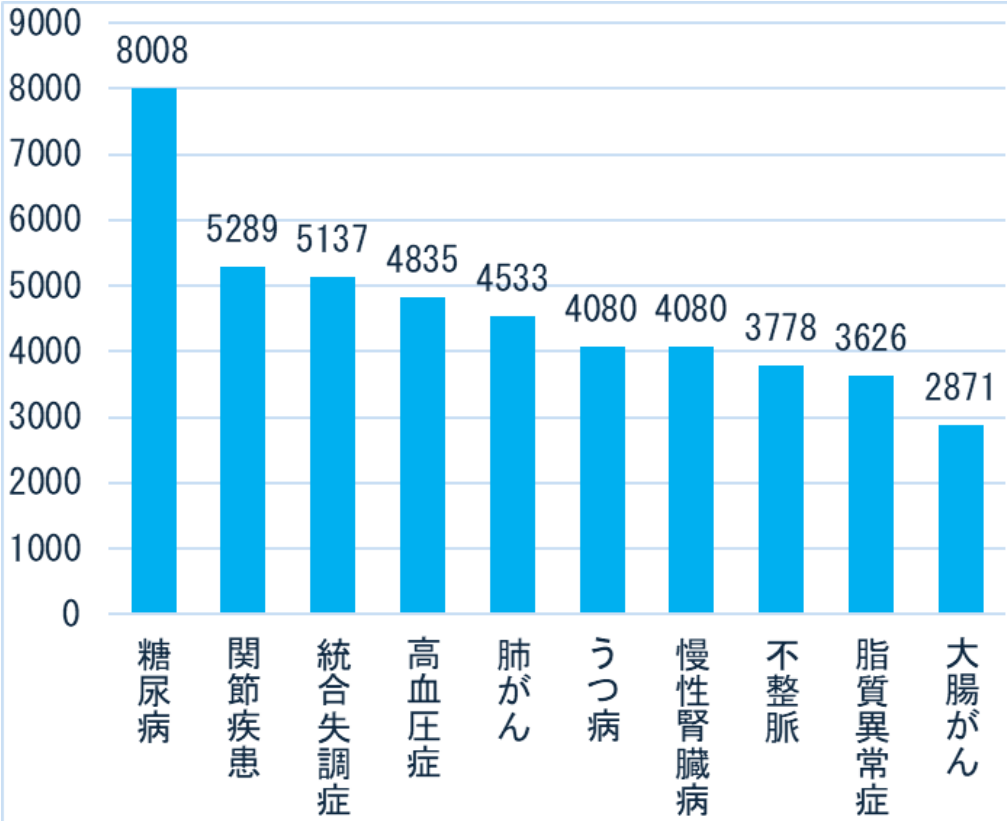
高齢独居世帯の割合
2000～2020年



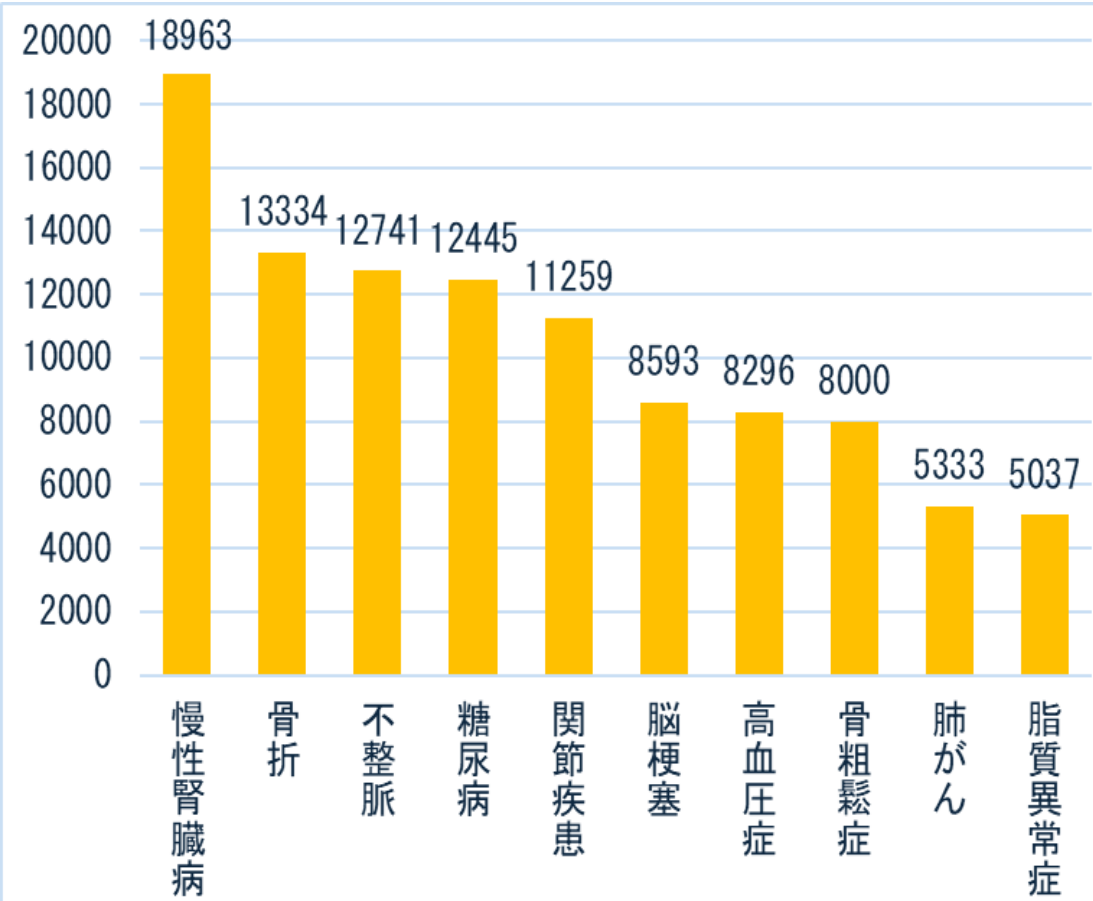
[出典] 地域包括ケア「見える化」システム 2024/06/16取得

https://mieruka.mhlw.go.jp/mieruka/webapp/S020100_init

名古屋市の疾病別総医療費（令和4年度上位10疾患）



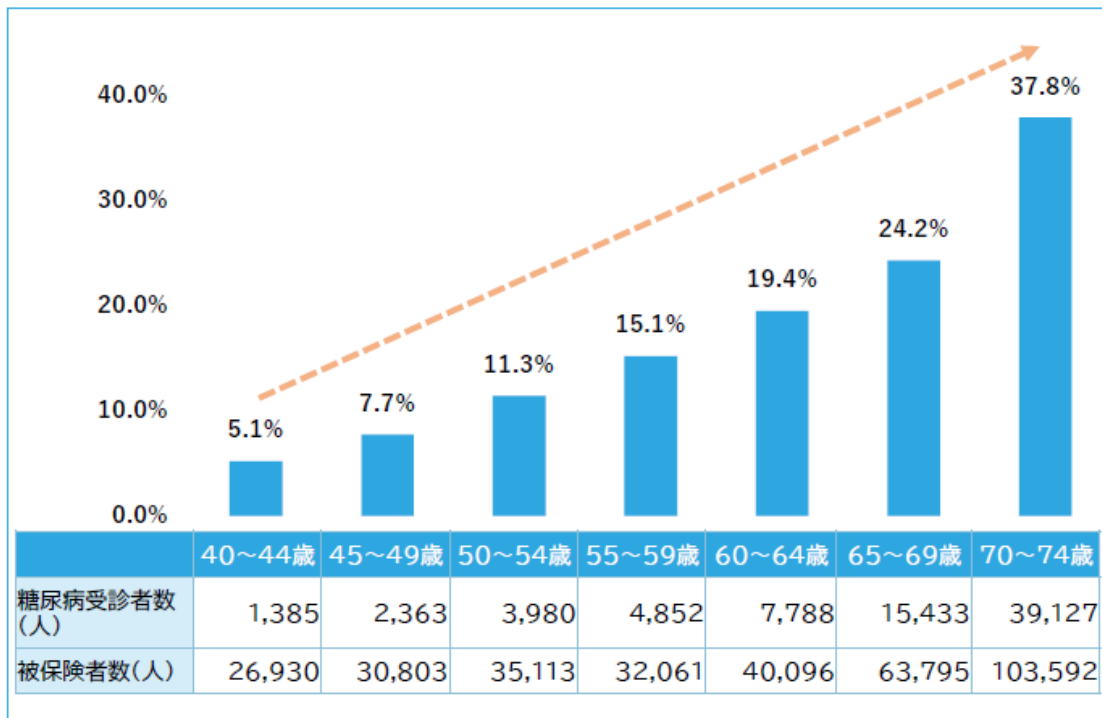
国民健康保険



後期高齢者医療制度

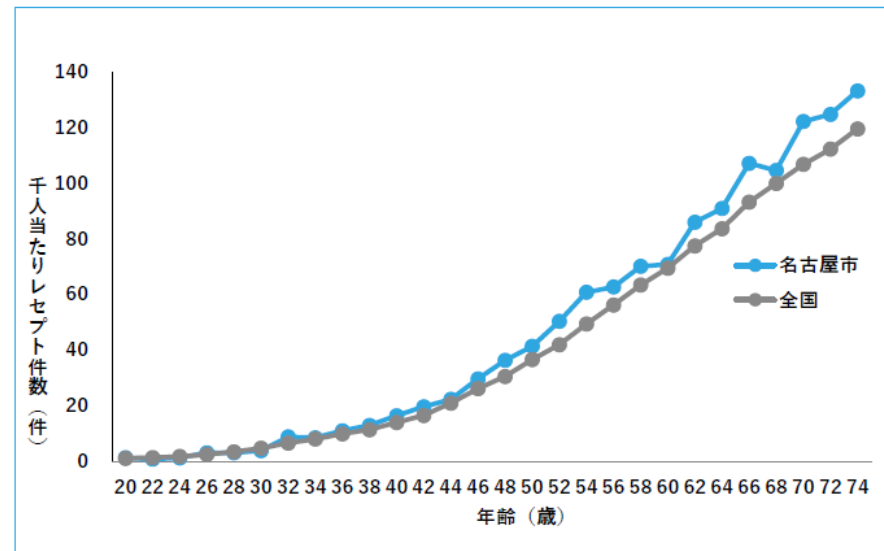
名古屋市KDBデータから見た 糖尿病の受診状況

▶ 糖尿病の受診者数・受診率(年齢階層別)



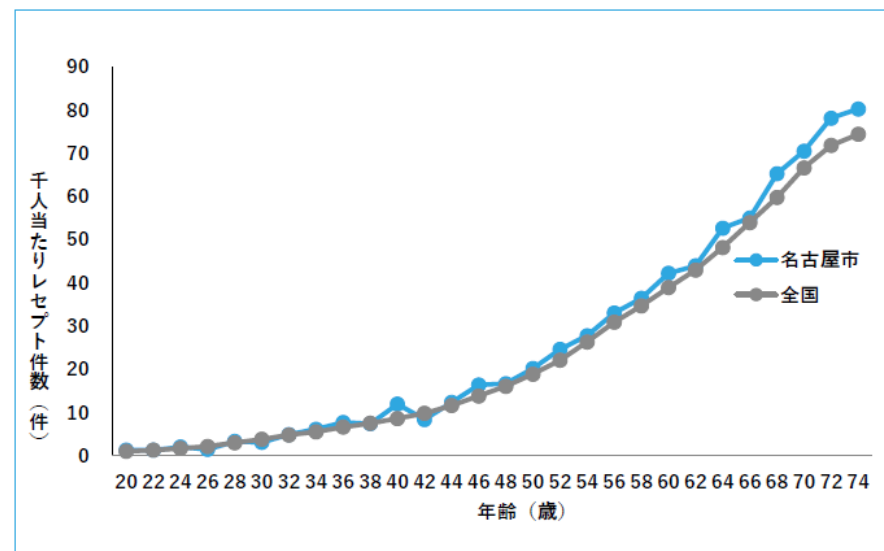
資料:KDBデータ(令和4年度)

▶ 糖尿病の千人当たりレセプト件数(男性)



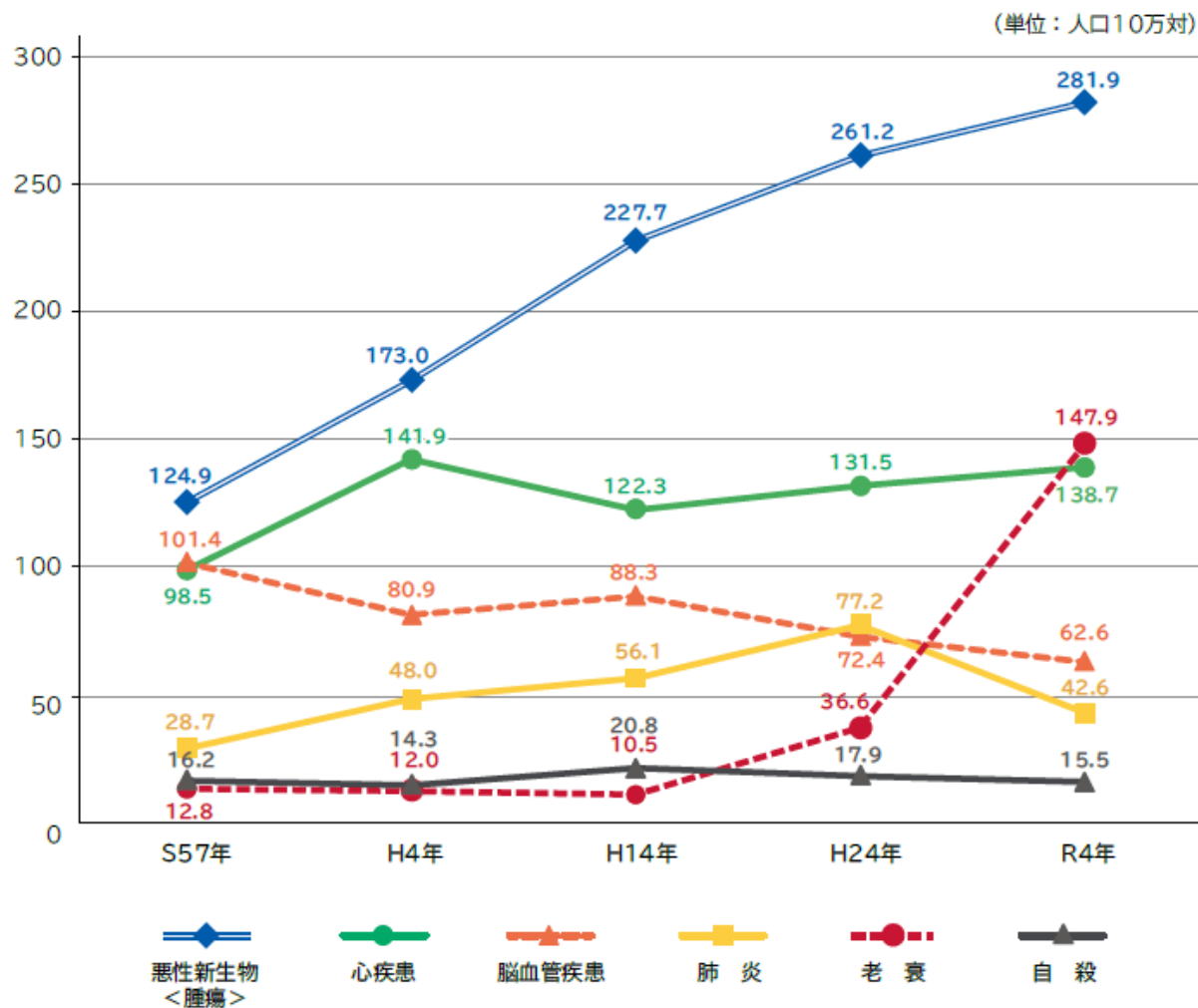
資料:KDBデータ(令和4年度)

▶ 糖尿病の千人当たりレセプト件数(女性)



資料:KDBデータ(令和4年度)

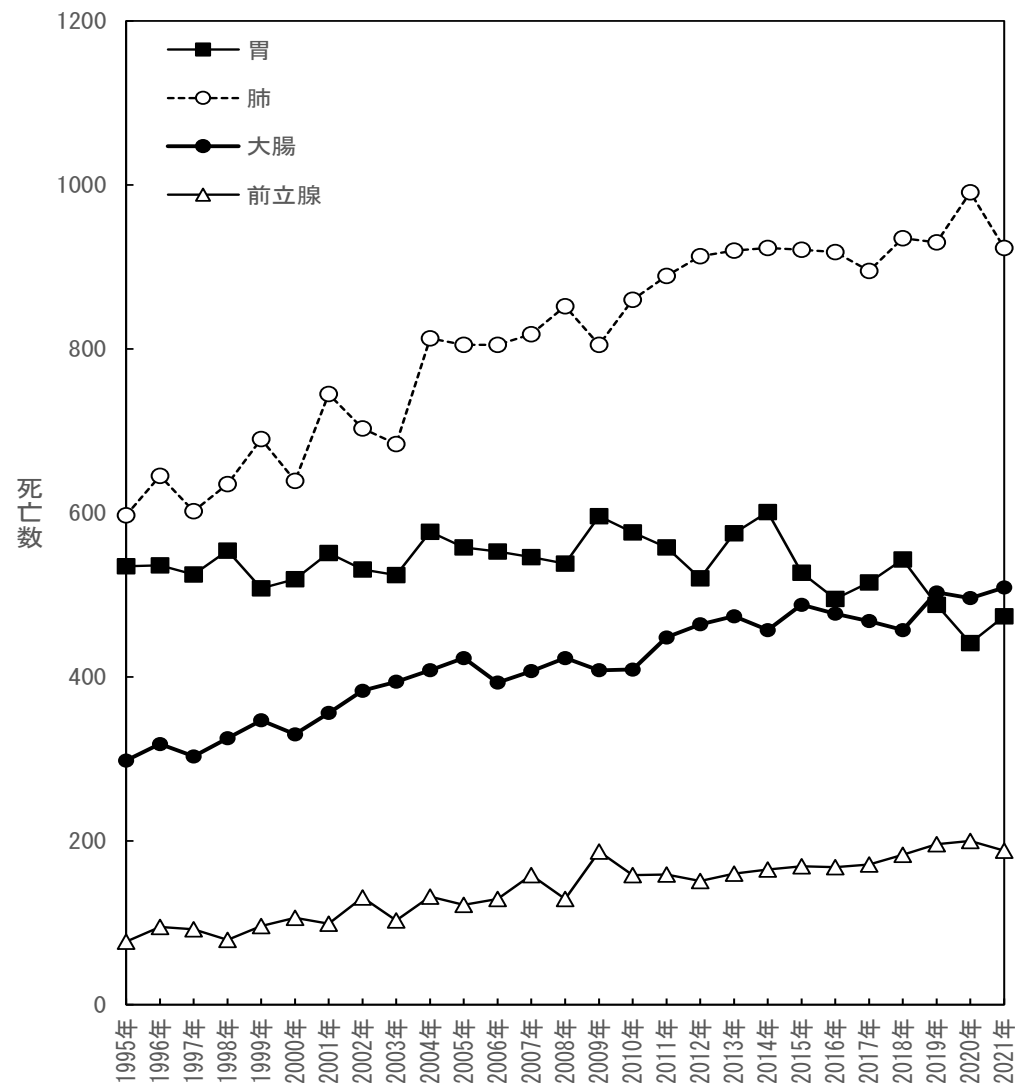
名古屋市における主な死因別死亡率の年次推移



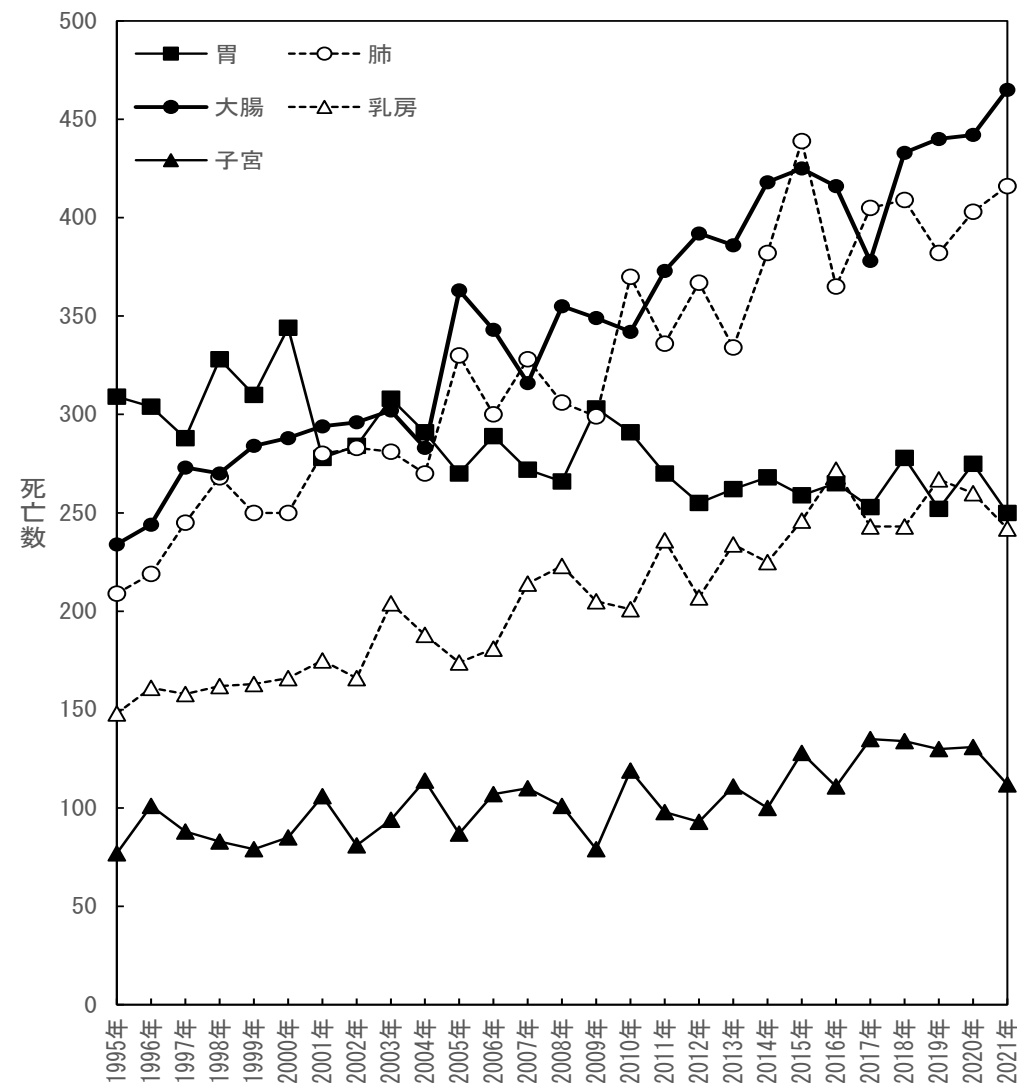
悪性新生物による死亡状況

主な部位別にみた死亡数の推移

男性（名古屋市・全年齢）



女性（名古屋市・全年齢）



名古屋市のがん検診

事業等	事業内容	令和4年の実績
ワンコインがん検診	胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん及び前立腺がんの各検診について、自己負担金500円で実施	受診者数 胃がん : 59,116人 大腸がん : 137,901人 肺がん : 142,623人 子宮がん : 95,371人 乳がん : 51,341人 前立腺がん: 66,290人

事業等	事業内容	実績
がん検診推進事業	大腸がん、子宮頸がん、乳がんの各検診について、特定の年齢の方を対象に検診手帳及び無料で受診できるクーポン券を配付	受診者数 大腸がん : 19,264人 子宮頸がん: 19,174人 乳がん : 18,964人
	無料クーポン券対象者への個別受診再勧奨を実施	対象者数 206,759人
	ナッジ理論を活用した個別受診勧奨を実施	対象者数 139,154人

名古屋市City of Nagoya

文字の大きさ

大きくする

元に戻す

読みふりがな

名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111 (代表)所在地, 地図

トップページ

暮らしの情報

観光・イベント情報

市政情報

事業向け情報

トップページ

暮らしの情報

健康と子育て

健康づくりのために

がん検診・生活習慣病健診のご案内

(現在の位置)

がん検診等のがん対策

がん対策

SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

Facebook

でシェア

X (旧Twitter)

でポスト

LINE

で送る

このページを印刷する

ページID: 62508

最終更新日: 2025年4月1日

令和7年度がん検診推進事業（無料クーポン券）についてのお知らせ

令和6年度より、無料クーポン券の対象となる検診の種類が拡大しています。

これまでの大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診に加え、胃がん検診・肺がん検診・前立腺がん検診の3種類を追加します。

特定の年齢に達した名古屋市民の方に対して、令和7年6月中に、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診の費用が無料となるがん検診無料クーポン券を送付する予定です。

がん検診推進事業（無料クーポン券）について、詳しくはこちらをご覧ください。

腹部超音波スクリーニング検査開始のお知らせ

令和7年2月1日より、50歳以上の方（年度末時点の年齢）を対象に、自己負担金500円で腹部超音波スクリーニング検査を開始しています（免除制度あり）。

腹部超音波スクリーニング検査について、詳しくはこちらをご覧ください。

トピックス

名古屋市では、がん検診をはじめ、がんに関する相談・情報提供、がんに関する学習、喫煙対策など、がんに関する様々な取り組みを行っています。

がん検診のご案内

がん相談・情報サロン「ピアネット」

がんに関する学習補助教材「がんについて考えようーがんの正しい知識と理解のためにー」

がん教育における外部講師の活用について

喫煙対策

がん対策の実施状況について

口のがん（口腔がん）のセルフチェックについて

名古屋市広報特番「最新がん事情！ 知って”安心”10のコト」

健康とは？

まず、健康についてあらためて考えてみましょう

あなたにとっての健康とは？

日本国憲法の中の健康

- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。

（第25条） 1946年

WHO憲章による健康の定義（1948）

健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること。

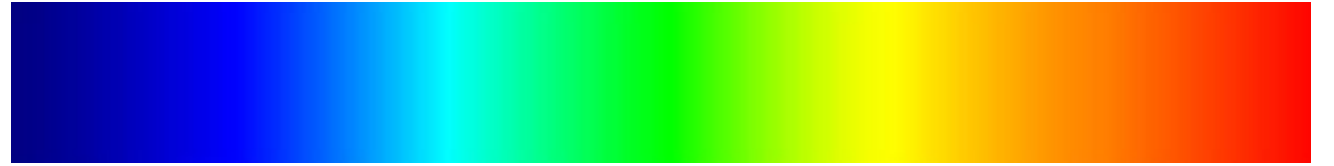
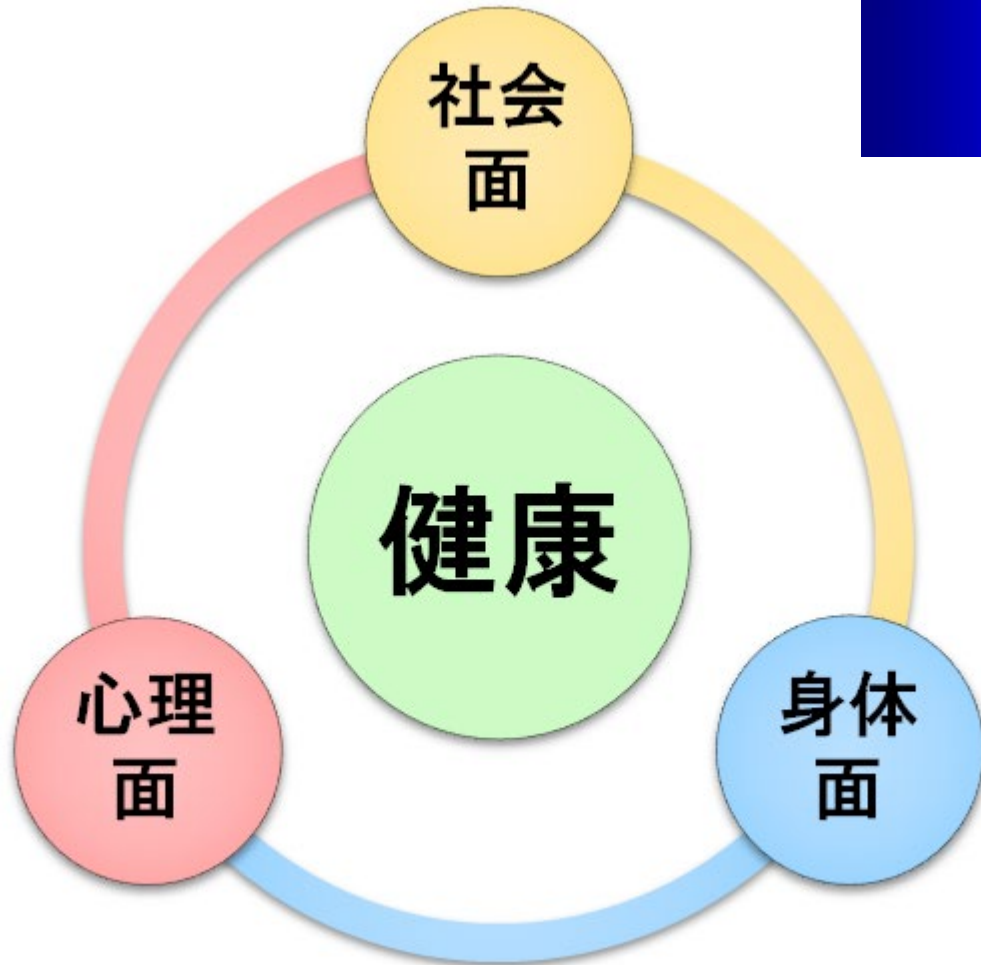
（日本WHO協会訳）

WHO definition of Health

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

何をもって「良い状態」と言えるのか...

健康の多面性



健康は連続体

WHO憲章（1948）

- 人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつである。
- 世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎であり、その成否は、個人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにかかっている。

公衆衛生の定義

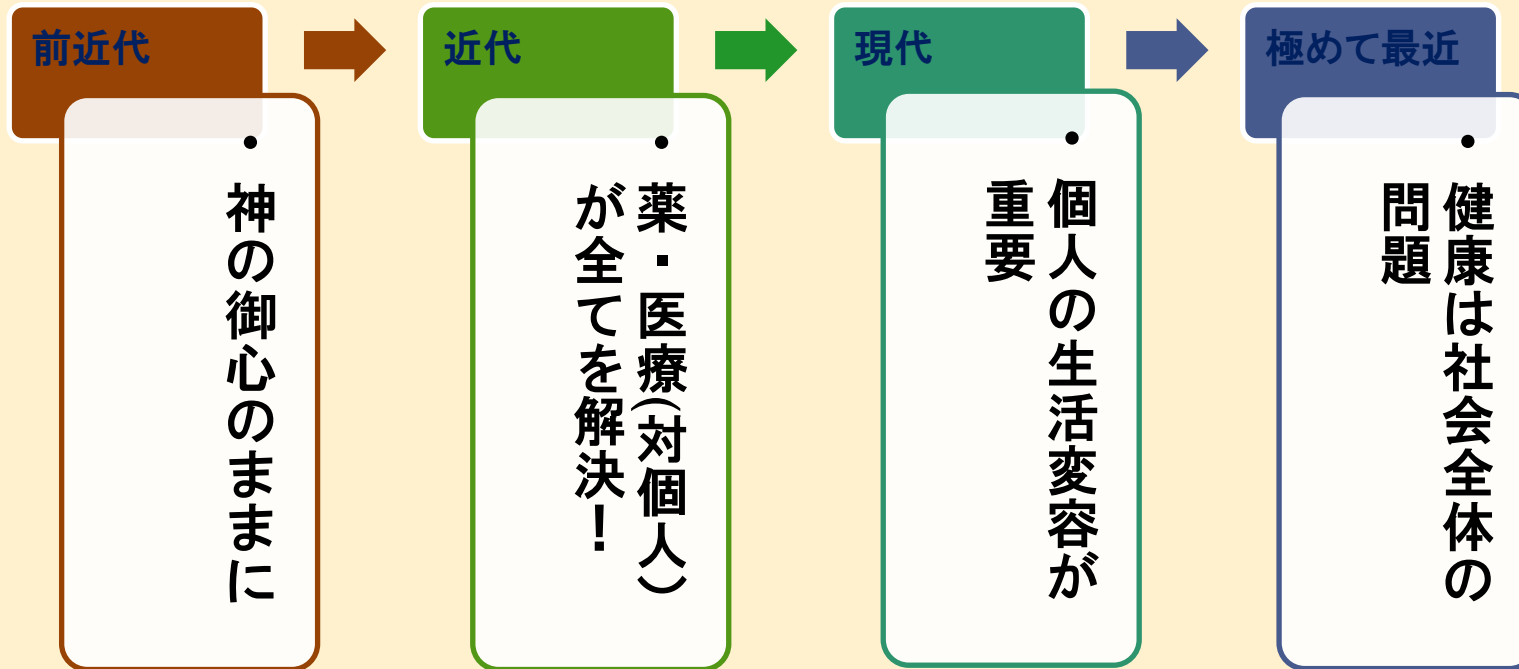
公衆衛生は、共同社会の組織的な努力を通じて、
疾病を予防し、寿命を延長し、身体的・精神的健康
と能率の増進をはかる科学・技術である。

C.E.A. Winslow; WHO(1949)

疾病予防

健康増進

健康増進へのアプローチ方法の変化



健康の決定要因として社会の影響はとても大きい!
(21世紀に入っての認識の変化)

なぜ感染症による死亡は激減したのか

- 衛生環境（上下水道）の整備
- 予防接種法の発明・普及
- 消毒法の発明・普及
- 抗生物質の発明・普及

トマス・マキューンの考察 1912-1988

1960~70年代に活躍

- バーミンガム大学公衆衛生学教授
- 医学史家
- 社会医学の提唱者
- イングランドとウェールズにおける死亡統計の分析
- 人口増加・感染症減少、健康の階級性について検討

トマス・マキューンの考察1912-1988

1960~70年代に活躍

- 医療は死亡率の低下に貢献していない。

1. 居住環境
2. 衛生状態
3. 安全な水
4. 栄養状態の改善

近代以前の感染症予防の古典的公衆衛生運動から
新時代へのパラダイムシフト

オタワ憲章 (1986年)

- 身体的、精神的、社会的に健全な状態に到達するには、個々人や集団が、望みを明確にし、それを実現し、ニーズを満たし、環境を変え、それにうまく対処していくことができないといけない。

○健康の前提条件：

- 平和、住居、教育、食物、収入、安定した生態系、生存のための諸資源、社会的正義と公正
- 健康増進は個人の生活習慣の改善に留まらず、社会的に環境を改善・整備することが必要。

健康は個人的努力だけでは達成されない。
社会的環境整備、資源開発が必要。

マイケル・マーモット卿

- ロンドン大学の疫学と公衆衛生学の教授。ロンドン大学の「健康の公正研究所の責任者」
- 1976年から英国公務員男性の職階と健康に関する研究（ホワイトホール研究）に参加する。のちに英国公務員男女を対象としてさらに範囲を広げた研究（第2期ホワイトホール研究）を行った。
- WHOの健康の社会的決定要因委員会（2005-8）と、社会的決定要因と健康格差に関するヨーロッパ報告の責任者を務めた。勧告はWHO総会や多くの国で採用された。英国政府も社会的要因と健康の不平等に関する報告を指揮を任命した。
- 2010年から2011年の英国医師会長を務め、2015年から2016年の第66代世界医師会長を務めた。 Wikipediaより



The Solid Facts (WHO) 2003

健康の社会的決定要因

これらの要因は、個人の選択に依らず、社会的・経済的・環境的な条件によって形成される。

- 社会格差
- ストレス
- 幼少期の発達
- 社会的排除
- 労働環境
- 失業
- 社会的支援
- 薬物依存
- 食品
- 交通手段

<https://www.tmd.ac.jp/med/hlth/whocc/pdf/solidfacts2nd.pdf>

日本語版が閲覧・ダウンロード可能

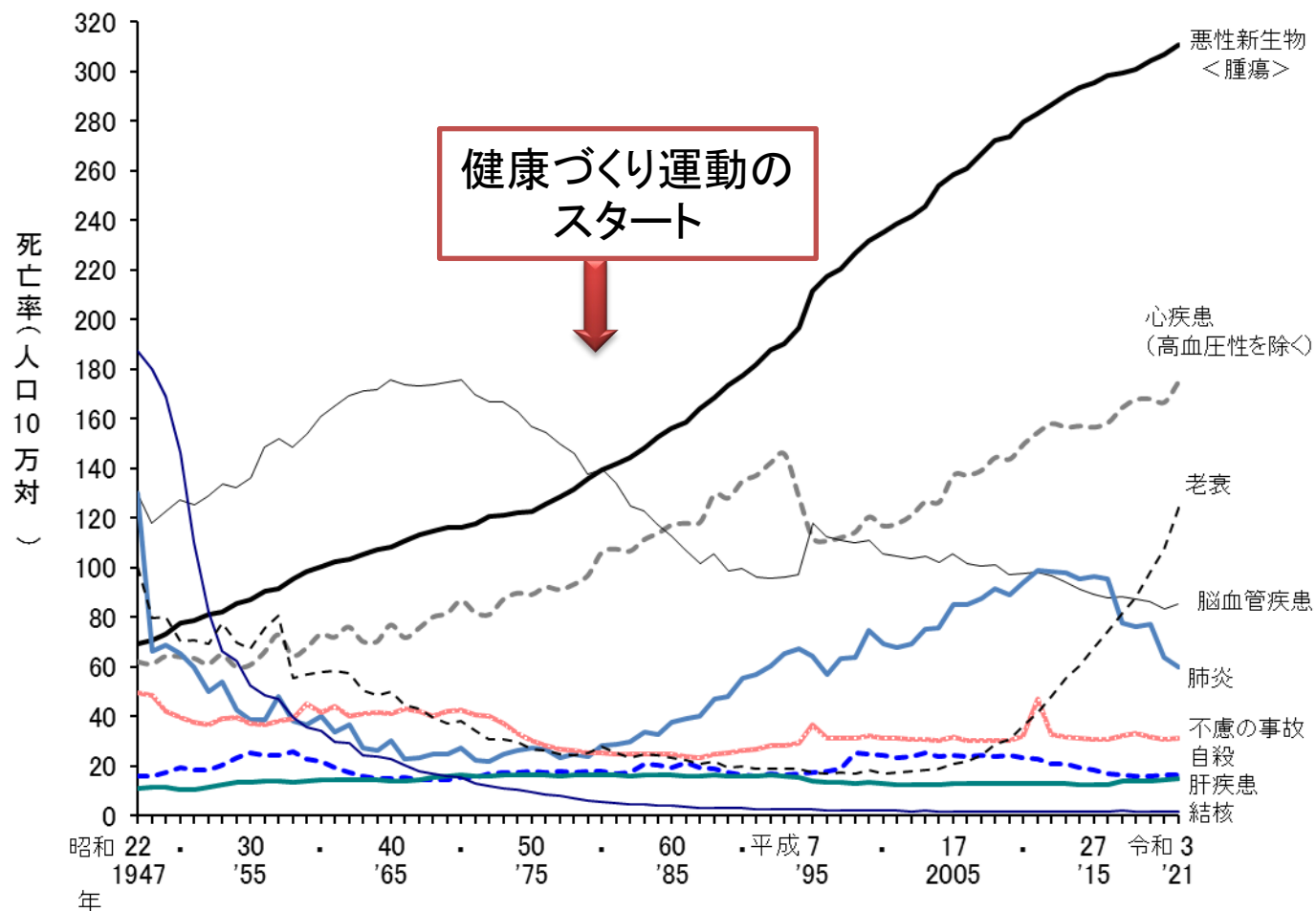
健康を既定する普遍的社会的要因

自分の人生に対し、どれだけの自由度を得ているか

社会に対し、どれだけ接点を持ち、社会的活動に参加しているか

Michel Marmot 2004

主な死因別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移

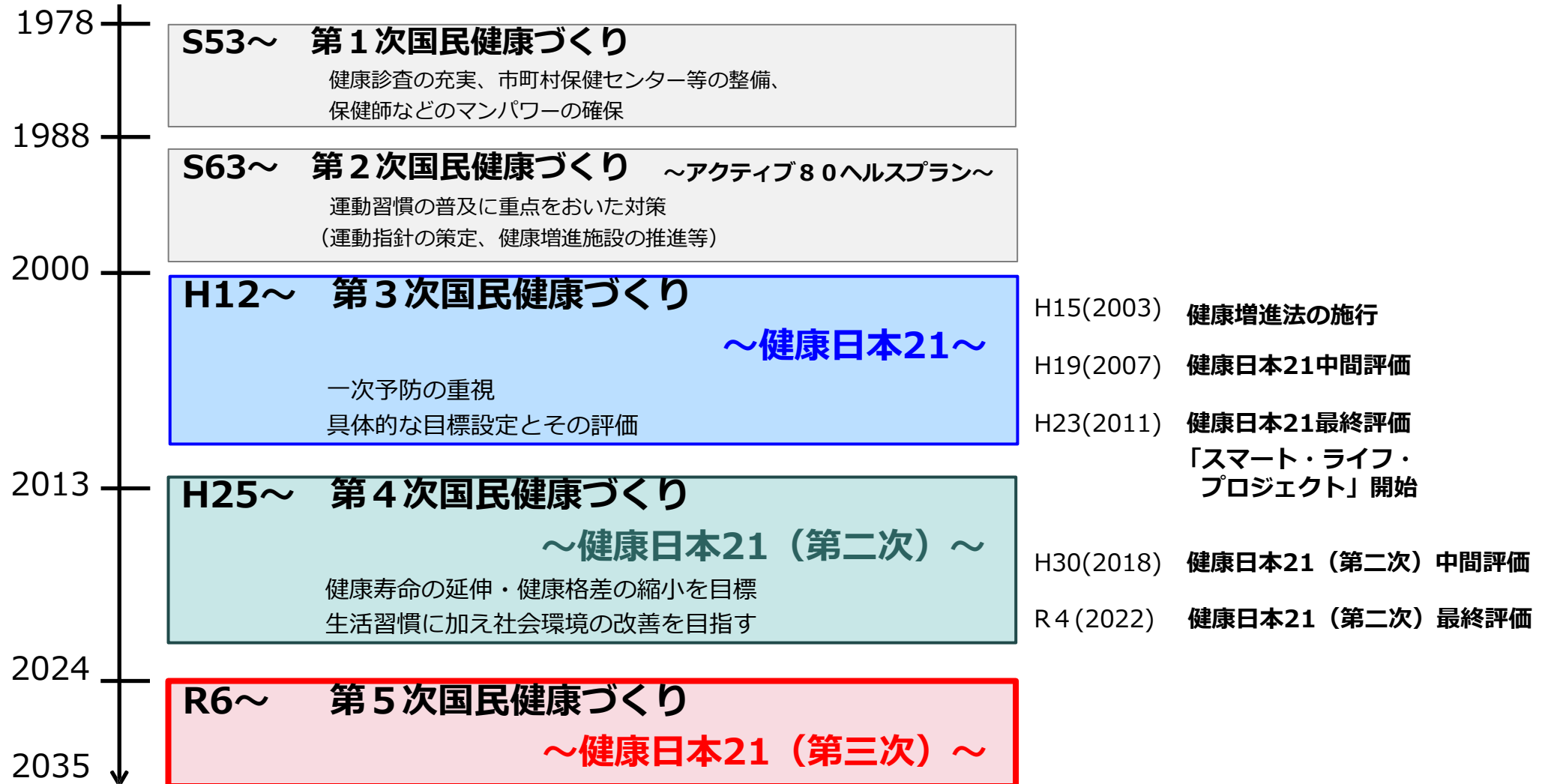


- 注：1) 平成6年までの「心疾患(高血圧性を除く)」は、「心疾患」である。
 2) 平成6・7年の「心疾患(高血圧性を除く)」の低下は、死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
 3) 平成7年の「脳血管疾患」の上昇の主な要因は、ICD-10(平成7年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。
 4) 平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況より

我が国における健康づくり運動

○平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を展開してきた。



健康増進法 2002年公布、2003年施行

- 国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するために、医療制度改革の一環としてつくられた法律。
- 「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」(第2条)とし、健康づくりに取り組むことを国民の責務としている。

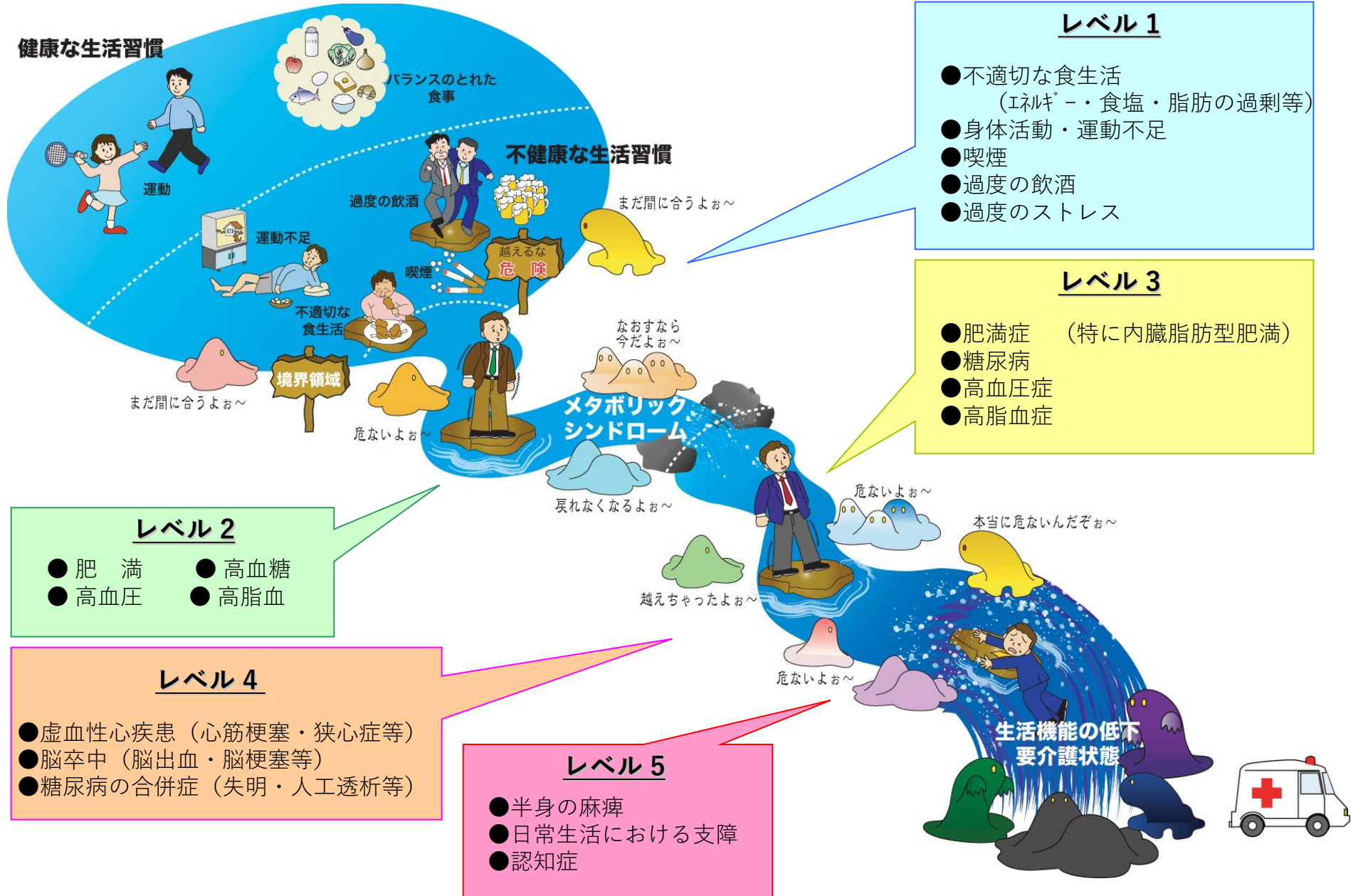
大きくは以下の4つが規定されている。

1. 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定
2. 都道府県、市町村における健康増進計画の策定
3. 健康診査の実施等に関する指針の策定
4. 国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設、受動喫煙の防止等

健康日本21とは

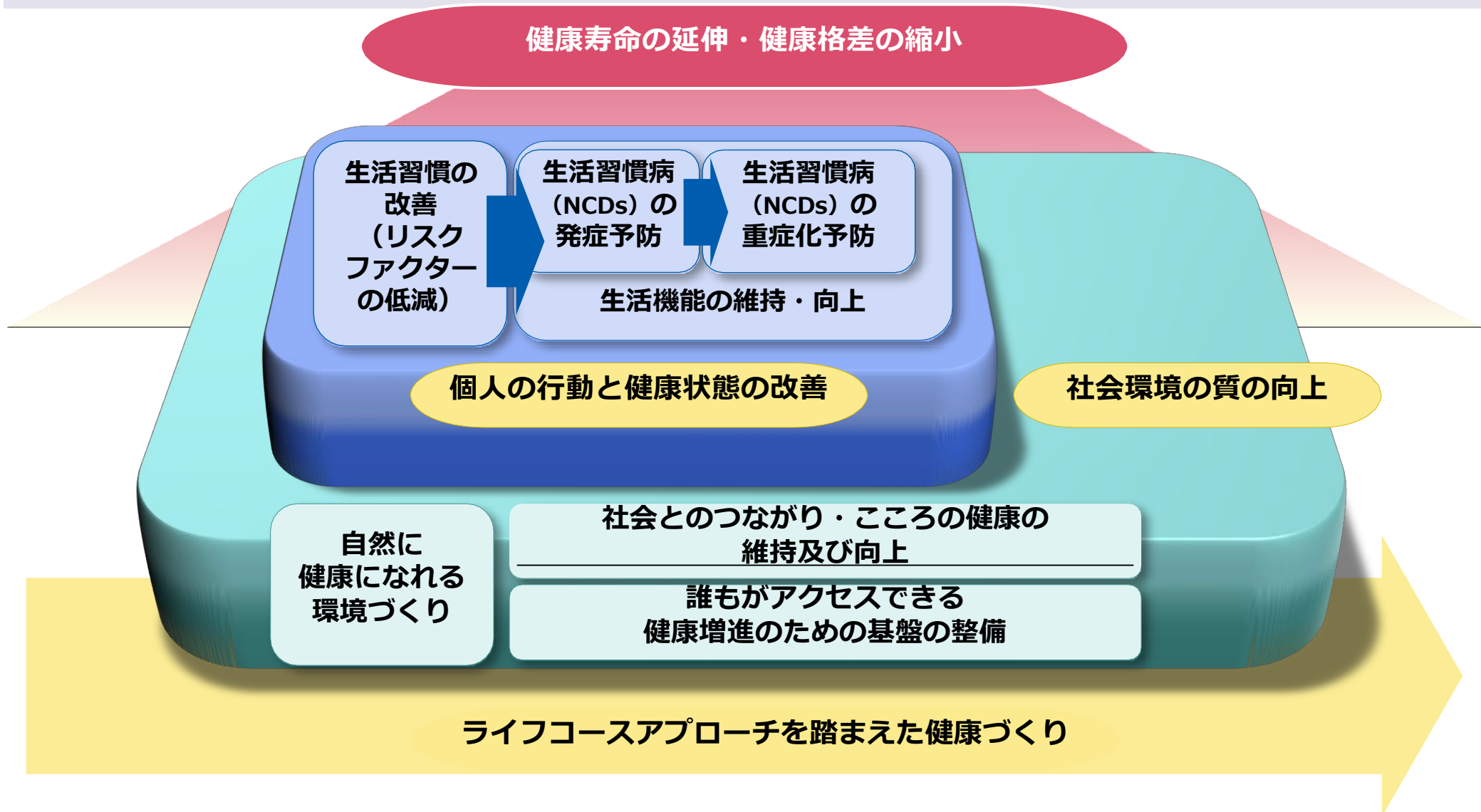


- 健康増進法に基づき策定された「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成15年厚生労働省告示第195号）」は、国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向や国民の健康の増進の目標に関する事項等を定めたもの。
- 令和6年度からいわゆる「健康日本21（第3次）」が開始。



健康日本21（第三次）の概念図

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める



健康日本21(第3次)の全体像



健康日本21(第3次)の基本的な方向と領域・目標

個人の行動と健康状態の改善

生活習慣の改善	栄養・食生活	適正体重を維持している者、肥満傾向児、バランスの良い食事、野菜・果物・食塩の摂取量
	身体活動・運動	歩数、運動習慣者、こどもの運動・スポーツ
	休養・睡眠	休養が取れている者、睡眠時間、週労働時間
	飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者、20歳未満の飲酒
	喫煙	喫煙率、20歳未満の喫煙、妊婦の喫煙
	歯・口腔の健康	歯周病、よく噛んで食べることができる者、歯科検診受診率
生活習慣病(NCDs)の 発症予防/重症化予防	がん	年齢調整罹患率・死亡率、がん検診受診率
	循環器病	年齢調整死亡率、高血圧、脂質高値、メタボ該当者・予備群、特定検診・特定保健指導
	糖尿病	合併症(腎症)、治療継続者、コントロール不良者、有病者数、メタボ該当者・予備群、特定健診・特定保健指導
	COPD	死亡率
生活機能の維持・向上		ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症検診受診率、心理的苦痛を感じている者

健康日本21(第3次)の基本的な方向と領域・目標

社会環境の質の向上

社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上	地域の人々とのつながり、社会活動、共食、メンタルヘルス対策に取り組む事業場
自然に健康になれる環境づくり	食環境イニシアチブ、歩きたくなるまちなかづくり、望まない受動喫煙
誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備	スマート・ライフ・プロジェクト、健康経営、特定給食施設、産業保健サービス

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり	こども	こどもの運動・スポーツ、肥満傾向児、20歳未満の飲酒・喫煙
	高齢者	低栄養傾向の高齢者、ロコモティブシンドローム、高齢者の社会活動
	女性	若年女性やせ、骨粗鬆症検診受診率、女性の飲酒、妊婦の喫煙

「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」という大きな目標に向け、「個人」の行動と健康状態の改善、同時に「社会」環境の質の向上を目指し、「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」にも取り組んでいきます。

健康なごやプラン21

第3次

計画期間

令和6年度～令和17年度(12年間)

健康なごや プラン21 とは？

すべての市民のみならず、健康で心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、健康寿命の延伸、生活の質の向上、生活習慣病の予防などを目的とした計画です。

各分野における目標や、市民のみなさまが取り組むべき行動をわかりやすく設定し、みなさまの生涯にわたる健康づくりを支援していきます。

▶ 次ページから特に市民のみなさまに身近な内容をまとめています。

●健康なごやプラン21(第3次)の構成

すべての市民が健康で心豊かに生活できる持続可能な社会の実現

健康寿命の延伸

生活の質の向上

生活習慣病の予防

子育て家庭の支援

6つの視点
での働きかけ

- 1 生活習慣の改善
- 2 生活習慣病の発症予防・重症化予防
- 3 生活機能の維持・向上
- 4 母子保健の推進
- 5 社会環境の質の向上
- 6 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

分野(16分野)

個人の行動と健康状態の改善(9分野)

- ①栄養・食生活 ②身体活動・運動
③休養・こころの健康づくり ④たばこ・COPD
⑤アルコール ⑥歯・口腔の健康
⑦循環器疾患・糖尿病 ⑧がん ⑨予防接種・各種検診

母子保健の推進(4分野)

- ⑩思春期の保健対策の強化と心身両面の健康づくり
- ⑪妊娠・出産に関する安心と安全性の確保と健康づくり
- ⑫小児保健水準の向上
- ⑬子どものこころの安らかな発達と育児不安の軽減

社会環境の質の向上(3分野)

- ⑭社会とのつながり
- ⑮自然に健康になれる環境づくり
- ⑯誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備

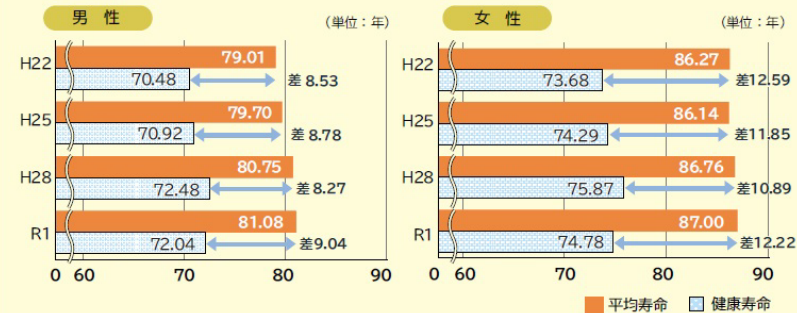
令和6年3月 名古屋市

健康寿命の延伸を目指します！

現状では、男女とも平均寿命と健康寿命に10年程度の差があります。

市民のみなさまのとりくみと市のとりくみを進めることで、この差を縮め、市民のみなさまの生活の質の向上を目指します。

●平均寿命と健康寿命の差の推移



なごや健康ガイド

がん検診をはじめとする各種検診の目的や内容のほか、生活習慣病や歯科口腔保健など、様々な健康に関する情報を市民のみなさまに提供するため、毎年4月に市内全世帯に配布しています。

● 詳細はこちらから

名古屋市健康福祉局健康部健康増進課

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話 番号 052-972-2637
ファックス 052-972-4152
電子メール a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

● 詳細は、市公式ウェブサイトからご覧ください。

健康なごやプラン 21

検索

<https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-4-3-0-0-0-0-0-0-0.html>

健康なごやプラン21(第3次)における「分野7・循環器疾患・糖尿病」の目標・指標

目 標	指 標		現状値 (令和4年度)	目標値 (令和15年度)
高血圧を改善する	収縮期血圧が140mmHg以上の人の割合	男性	28.3%※1	26.3%(R11年度)※4
		女性	23.9%※1	20.7%(R11年度)※4
脂質異常症の人を減らす	LDLコレステロール値が160mg/dl以上の人の割合	男性	9.6%※1	7.2%(R11年度)※4
		女性	14.4%※1	10.8%(R11年度)※4
糖尿病の合併症(糖尿病性腎症)を減らす	新規透析導入患者数(被保険者10万人当たり人数)		54.1※1	46.1(R11年度)※4
糖尿病治療を継続する人の割合を増やす	糖尿病治療継続者の割合(HbA1cが6.5%以上の人のうち、服薬治療している人の割合)		72.3%※1	75.0%(R11年度)※4
血糖コントロール不良者の割合を減らす	血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合(HbA1cが8.0%以上の人の割合)		1.39%※1	1.04%(R11年度)※4
糖尿病の人の増加を抑制する※5	糖尿病有病者の割合(HbA1cが6.5%以上の人の割合)	男性	13.5%※1	14.1%(R11年度)※4
		女性	6.6%※1	6.9%(R11年度)※4
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を減らす	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合		31.7%※2	25.8%(R11年度)※4
特定健康診査・特定保健指導等の実施率を向上させる	特定健康診査実施率		31.4%※2	38.6%(R11年度)※4
	後期高齢者医療健康診査実施率		24.7%※3	37.0%(R11年度)※6
	特定保健指導実施率		6.4%※2	12.6%(R11年度)※4

※1 名古屋市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導等実績値

※2 名古屋市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導法定報告値

※3 後期高齢者医療健康診査実績値

※4 名古屋市国民健康保険保健事業実施計画における令和11年度の目標値

※5 国の将来予測値では更なる増加が予測される中、増加の抑制を目標とする

※6 愛知県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画を参考に令和11年度の目標値とする

<https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-4-3-0-0-0-0-0-0-0.html>

ご清聴ありがとう
ございました



名古屋市開府400年記念
キャラクターはち丸くん

The End